**PFE - Pleito de Financiamento Externo**
**Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo – ARAS SP**

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001011/2025-23
Código do pleito: 7762622899/2025

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 02
1. 2. 3. Soluções . . . . . 04
1. 2. 4. Resultados . . . . . 07
1. 3. Objetivo . . . . . 08
1. 4. Indicadores . . . . . 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 13
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 14
1. 4. 9. Informações do 9° indicador . . . . . 14
1. 4. 10. Informações do 10° indicador . . . . . 15
1. 5. Componentes . . . . . 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 18
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 19
1. 5. 4. Informações do 4° componente . . . . . 21
1. 5. 5. Informações do 5° componente . . . . . 22
1. 6. Beneficiários . . . . . 25
1. 7. Anexos . . . . . 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 27
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 27
2. 2. Anexos . . . . . 29
3. GESTÃO . . . . . 30
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 30
3. 1. 1. Descrição . . . . . 30
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 31
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 31
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 32
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 32
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 34
3. 4. Anexos . . . . . 36
4. RISCOS . . . . . 37
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 37
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 39
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 41
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 42
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 45
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 48
4. 7. Anexos . . . . . 50
5. FINANCIAMENTO . . . . . 51
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 51

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 51
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 53
5. 3. Contragarantias . . . . . 54
5. 4. Anexos . . . . . 54
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 55
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 55
6. 2. Anexos . . . . . 56
7. CONTATOS . . . . . 57
7. 1. Contatos . . . . . 57
7. 2. Anexos . . . . . 58
.

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo – ARAS SP
**Sigla:** ARAS SP
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Estado de São Paulo

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

Localizado na região sudeste do Brasil, o Estado de São Paulo abrange apenas 3% do território nacional, mas concentra aproximadamente 44,4 milhões de habitantes, equivalentes a 21% da população do país (IBGE, 2022). Também é responsável por cerca de 32,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,806, colocando-o entre as unidades federativas com os melhores indicadores socioeconômicos do país. Ainda assim, convive com grandes contrastes internos, uma vez que regiões como o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Itapeva registram municípios com IDH tão baixos quanto 0,639, retratando pontos de acentuada vulnerabilidade social.

**Contexto Social**
O Estado de São Paulo enfrenta desafios crescentes em relação à pobreza e à extrema pobreza. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 62,9 milhões de brasileiros viviam, em 2021, com renda domiciliar per capita de até R$ 497,00 mensais — um incremento de quase 10 milhões de pessoas em comparação a 2019. No recorte paulista, o percentual da população em situação de pobreza passou de 12,79% em 2012 para 17,85% em 2021, afetando majoritariamente mulheres, negros e pessoas de 30 a 59 anos. Além disso, há destaque para populações quilombolas, indígenas e privadas de liberdade, historicamente excluídas e que ainda enfrentam barreiras para acessar serviços essenciais, incluindo saúde.

A malha urbana de São Paulo conta com 645 municípios, número superado apenas por Minas Gerais. Tal fragmentação administrativa, aliada às intensas desigualdades, gera arranjos locais muito diversos no que tange à oferta de infraestrutura e políticas públicas. Setores censitários com até 50 famílias em pobreza ou extrema pobreza estão espalhados por todo o Estado, enquanto setores com mais de 300 famílias nessa condição se concentram em áreas específicas, frequentemente nas periferias de grandes centros ou em municípios de menor dinamismo econômico.

**Contexto Econômico**
Embora seja o principal polo industrial do Brasil e sedie grande parte da produção econômica nacional, São Paulo não apresenta um crescimento uniforme em todas as regiões. A maior oferta de emprego e renda está concentrada em áreas metropolitanas e em cidades próximas a eixos de desenvolvimento, enquanto municípios mais afastados carecem de oportunidades e incentivos. Essa assimetria econômica impacta diretamente a capacidade local de investir em infraestrutura e consolidar serviços de saúde, uma vez que as receitas municipais tendem a ser menores em áreas de vulnerabilidade.

As disparidades regionais influenciam o próprio padrão de urbanização. Enquanto na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) — que abriga cerca de 21 milhões de habitantes e grande parte do PIB estadual — há concentração de serviços e equipamentos de média e alta complexidade, municípios menores têm dificuldade de oferecer uma rede de atenção à saúde que supra as demandas de sua população. Consequentemente, formam-se fluxos de deslocamento para os grandes centros, aumentando a pressão sobre os serviços ali disponíveis.

**Contexto Político-Institucional**
O Estado de São Paulo organiza o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de 18 macrorregiões e 62 regiões de saúde, conhecidas como Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS). Esse recorte visa articular os diversos níveis de atenção — primária, especializada e hospitalar —, de modo a otimizar recursos e distribuir melhor a oferta de serviços. Na prática, porém, persistem desafios de governança, gestão e financiamento, que são potencializados pela alta demanda e pelas diferenças socioeconômicas no território.

A rede de estabelecimentos de saúde do SUS em São Paulo reflete essa diversidade. Apesar de o estado contar com importantes centros universitários, rede de ambulatórios e hospitais e de referência, a distribuição desses equipamentos segue os eixos de maior desenvolvimento econômico, resultando em disparidades no acesso. Ademais, alguns hospitais e unidades especializadas apresentam deficiências físicas e tecnológicas, dificultando a adoção de novas práticas e a ampliação do atendimento.

**Análise Situacional:** Em síntese, o contexto em que se insere a iniciativa para fortalecimento das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) no Estado de São Paulo é marcado pela coexistência de regiões com alto desenvolvimento e outras com marcantes carências em infraestrutura, cobertura de serviços e indicadores de saúde.

A organização do SUS paulista em macrorregiões, embora avance na descentralização, ainda enfrenta lacunas estruturais que dificultam a equidade no acesso, a eficácia do cuidado e a racionalidade no uso dos recursos. Esse panorama, respaldado por dados oficiais sobre população, pobreza, distribuição de equipamentos e perfil epidemiológico, evidencia a necessidade de ações planejadas que respondam às diferenças sociais e promovam maior eficiência dos serviços de saúde, garantindo uma atenção integral à população.

1. 2. 2. **Problema:**

A realidade de saúde no Estado de São Paulo, revela um conjunto de problemas e necessidades que configuram um cenário de fragilidades e demandas não atendidas em diversos pontos do território:

1. 2. 2. 1.

**Desigualdades Regionais na Disponibilidade de Serviços**

- 1. 2. 2. 2.

  Os dados oficiais demonstram que, apesar de São Paulo contar com 559 hospitais participantes do SUS, 1.849 ambulatórios de especialidades e 411 unidades de pronto atendimento, a maioria dessas estruturas concentra-se em municípios economicamente mais dinâmicos, deixando vazios assistenciais em áreas de menor desenvolvimento.

- 1. 2. 2. 3.

  O Índice de Dependência Regional (IDR) retrata a dificuldade de muitas regiões em garantir, internamente, procedimentos de média e alta complexidade. Em Itapetininga, por exemplo, o IDR na alta complexidade chega a 95,53%, indicando que praticamente todos os casos mais complexos demandam deslocamentos a distâncias que podem superar 200 km.

- 1. 2. 2. 4.

  Consequência: grandes deslocamentos, sobrecarga das regiões polo, internações tardias e maior risco clínico aos pacientes.

1. 2. 2. 5.

**Crescimento da População em Situação de Pobreza ou Extrema Pobreza**

- 1. 2. 2. 6.

  A Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2022) aponta que temos hoje em números absolutos, milhões de famílias com renda domiciliar per capita de até R$ 497,00 mensais.

- 1. 2. 2. 7.

  Esse crescimento é mais expressivo em regiões com menores oportunidades de emprego e renda, favorecendo a disseminação de determinantes sociais negativos para a saúde (habitações precárias, saneamento insuficiente), o que reforça a demanda por serviços públicos.

- 1. 2. 2. 8.

  Consequência: intensificação das inequidades em saúde, pois famílias em maior vulnerabilidade têm menor acesso a diagnóstico e prevenção, gerando aumento de complicações médicas evitaveis.

1. 2. 2. 9.

**Perfil Epidemiológico Marcado por Doenças Crônicas e Altos Índices de Mortalidade**

- 1. 2. 2. 10.

De acordo com dados de 2011 a 2023, as doenças do aparelho circulatório ocupam a primeira posição nas causas de morte (28,8%), seguidas pelas neoplasias (18,6%) e doenças respiratórias (12,8%). Condições que exigem acompanhamento contínuo e acesso a procedimentos especializados.

- 1. 2. 2. 11.

  Ao mesmo tempo, registra-se tendência crescente de mortalidade por diabetes, doenças hipertensivas e neoplasias, relacionadas tanto ao envelhecimento populacional quanto à dificuldade de manejo clínico precoce na atenção básica.

- 1. 2. 2. 12.

  Mortalidade materna e infantil, com índices preocupantes, ocasionados pelas dificuldades de acesso e falta de integração entre a Atenção Primária e as Maternidades.

- 1. 2. 2. 13.

  Consequência: quando não há uma rede resolutiva em nível primário e intermediário, a sobrecarga recai sobre os hospitais e centros de referência, com longos tempos de espera.

1. 2. 2. 14.

**Falta de Integração e Governança entre Diferentes Níveis Assistenciais**

- 1. 2. 2. 15.

  Há carência de linhas de cuidado estabelecidas e protocolos clínicos uniformes, dificultando o fluxo dos pacientes.

- 1. 2. 2. 16.

  Em levantamentos oficiais, gestores municipais apontaram as dificuldades de referência e contrarreferência, inexistência de sistemas de informação interoperáveis e capacitação limitada de equipes como barreiras à implantação de ações conjuntas.

- 1. 2. 2. 17.

  Consequência: duplicação de esforços, descontinuidade do cuidado, aumento do tempo de espera para consultas especializadas e cirurgias eletivas, bem como dificuldade de monitoramento efetivo dos resultados em saúde.

1. 2. 2. 18.

**Infraestrutura e Parque Tecnológico Defasados**

- 1. 2. 2. 19.

  Parte expressiva das unidades hospitalares e ambulatoriais apresenta estrutura física inadequada ou obsoleta, com pouca renovação de equipamentos e ausência de modernização tecnológica. Levantamentos da Secretaria de Estado da Saúde sinalizam a necessidade de substituição de equipamentos de imagem (raios X, tomógrafos, ressonâncias) em várias regiões, especialmente nas mais afastadas dos grandes centros.

- 1. 2. 2. 20.

  As edificações também demandam adequações para atender a normas de segurança, conforto, acessibilidade e sustentabilidade.

- 1. 2. 2. 21.

  Consequência: limitação da capacidade diagnóstica e terapêutica, demora na detecção de condições graves e impossibilidade de adotar métodos modernos de cuidado em áreas com maior vulnerabilidade.

**Causas e Consequências Gerais**

- 1. 2. 2. 22.

  As causas desses problemas incluem: desigualdades econômicas históricas, concentração de investimentos em polos desenvolvidos, fragmentação da governança, falta de atualização tecnológica e políticas de sustentabilidade financeira insuficientes para as necessidades crescentes de uma população numerosa.

- 1. 2. 2. 23.

  As consequências estão expostas nos indicadores de saúde: altas taxas de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB), distâncias elevadas para acesso a cuidados especializados, mortalidade crescente por doenças crônicas e aumento da pressão orçamentária municipal e estadual.

Esses problemas formam a situação inicial que se deseja transformar. A partir de dados oficiais e estudos regionais, nota-se que a redução das disparidades territoriais, o aprimoramento da governança em saúde e a adequação estrutural e tecnológica constituem requisitos para a efetiva consolidação do SUS em São Paulo.

1. 2. 3. **Solução:**

Com base na análise prévia dos problemas e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo, foram organizadas ações em cinco componentes. As iniciativas estão alinhadas aos Objetivos Estratégicos 102, 214, 302 e 303 do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027:

1. **Apoio aos Processos de Gestão com Ênfase na Regionalização**

- 1. 2. 4.

  **Objetivo:** Integrar gestores e equipes para aprimorar a governança do SUS nas Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).

- 1. 2. 5.

  **Principais Ações:**

  - 1. 2. 6.

    Oficinas e Consultorias: articulação entre municípios e estado para elaboração de diagnósticos situacionais, planos e pactos regionais, reduzindo lacunas e duplicidades, com o Fortalecimento dos Comitês Regionais de Governança.

  - 1. 2. 7.

    Linhas de Cuidado: adoção de abordagens padronizadas que envolvem atenção primária, especializada e hospitalar, com foco nas doenças crônicas - DCNTs e Atenção Materno Infantil.

**Como atende aos problemas:**

- 1. 2. 8.

  Desigualdades Regionais: ao promover planejamento conjunto, reduz-se a concentração de serviços em poucos centros.

- 1. 2. 9.

  Populações Vulneráveis: ampliam-se as estratégias de prevenção e acompanhamento de grupos em situação de pobreza ou extrema pobreza.

- 1. 2. 10.

Perfil Epidemiológico: linhas de cuidado integradas possibilitam e garantem o manejo precoce, continuidade do tratamento e partos humanizados e seguros.

- 1. 2. 11.

  Governança e Integração: metodologias inovadoras e colegiados fortalecidos harmonizam a regulação de pacientes, eficiencia nas referências e contrarreferências, integrando a Atenção Primária à Atenção Especializada e às Maternidades.

Alinhamento com o PPA: OE 102 e OE 302

2. **Infraestrutura e Atualização do Parque Tecnológico**

- 1. 2. 12.

  **Objetivo:** Modernizar e adequar a estrutura física dos hospitais e serviços, ampliando a capacidade de atendimento de média e alta complexidade em diferentes regiões do estado.

- 1. 2. 13.

  **Principais Ações:**

  - 1. 2. 14.

    Reformas e Adequações Físicas: melhoria estrutural em hospitais sob gestão estadual.

  - 1. 2. 15.

    Aquisição de Equipamentos Modernos: foco em tecnologia de diagnóstico por imagem, laboratórios e suporte cirúrgico.

  - 1. 2. 16.

    Descentralização de Serviços: reforço das unidades de saúde em regiões que anteriormente careciam de estrutura de média e alta complexidade, reduzindo a demanda nos grandes polos.

**Como atende aos problemas:**

- 1. 2. 17.

  Desigualdades Regionais: ao disponibilizar ambientes hospitalares devidamente equipados em áreas periféricas, diminui-se o fluxo para grandes centros.

- 1. 2. 18.

  Infraestrutura Defasada: a renovação de equipamentos e adaptações físicas possibilitam procedimentos mais complexos próximos ao domicílio dos usuários.

- 1. 2. 19.

  Perfil Epidemiológico de DCNTs: equipamentos diagnósticos avançados permitem rastreamento e tratamento precoces.

- 1. 2. 20.

  Populações Vulneráveis: maior oferta de serviços especializados e resolutivos.

Alinhamento com o PPA: OE 102 e OE 214

3. **Inovação Digital – Saúde Digital**

- 1. 2. 21.

**Objetivo:** Implantar soluções tecnológicas que promovam integração de dados, agilidade nos atendimentos e melhoria da articulação entre diferentes níveis de atenção.

- 1. 2. 22.

**Principais Ações:**

- 1. 2. 23.

  Implantação de Prontuário Eletrônico e Telemedicina: infraestrutura de TI, conectando equipes.

- 1. 2. 24.

  Integração de Sistemas de Informação: plataformas interoperáveis que otimizam o encaminhamento de pacientes, o monitoramento de indicadores e a comunicação entre hospitais, ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

- 1. 2. 25.

  Capacitação em TIC: formação de profissionais para uso efetivo das novas ferramentas.

**Como atende aos problemas:**

- 1. 2. 26.

  Falta de Integração e Governança: a troca eletrônica de informações entre unidades reforça a continuidade do cuidado e aperfeiçoa a regulação de leitos.

- 1. 2. 27.

  Desigualdades Regionais: permite que especialistas atendam remotamente municípios menores e mais isolados, reduzindo deslocamentos, filas e custos.

- 1. 2. 28.

  Perfil Epidemiológico: facilita o acompanhamento contínuo de pacientes crônicos e gestantes, possibilitando intervenções precoces e melhor qualidade de vida.

- 1. 2. 29.

  Populações Vulneráveis: pessoas em áreas remotas, historicamente excluídas, passam a ter acesso a orientações médicas e diagnósticos.

Alinhamento com o PPA: OE 102 e OE 303

4. **Construção de Novo Hospital**

- 1. 2. 30.

  **Objetivo:** suprir a carência de serviços de média e alta complexidade em região estratégica, melhorando a cobertura assistencial e diminuindo longos deslocamentos.

- 1. 2. 31.

  **Principais Ações:**

  - 1. 2. 32.

    Hospital em Área Prioritária: escolha de local com altos Índices de Dependência Regional (IDR), - RRAS 8, com oferta de leitos e especialidades adequadas.

  - 1. 2. 33. Integração com a Rede Existente.

**Como atende aos problemas:**

- 1. 2. 34.

  Desigualdades Regionais: fortalece o atendimento em local tradicionalmente dependente de hospitais distantes, minimizando o impacto financeiro e social dos deslocamentos.

- 1. 2. 35.

  Infraestrutura Defasada: criação de hospitais com alto padrão de equipamentos e estrutura, suprindo lacunas crônicas.

- 1. 2. 36.

  Perfil Epidemiológico: a proximidade de serviços especializados melhora o manejo de doenças crônicas e partos de risco.

- 1. 2. 37.

  Populações Vulneráveis: beneficia grupos de renda mais baixa, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos.

Alinhamento com o PPA: OE 102 e OE 214

1. 2. 38. **Resultado:**

A implementação do projeto deverá transformar o cenário do SUS em São Paulo, proporcionando benefícios diretos e externalidades positivas que refletem a superação das lacunas identificadas. As melhorias se darão em diversas dimensões e serão observáveis de forma qualitativa. A seguir, detalham-se os resultados esperados, com o alinhamento sucinto aos Objetivos Estratégicos 102, 214, 302 e 303 do PPA 2024-2027:

- 1. 2. 39.

  **Maior Equidade no Acesso aos Serviços de Saúde:**
  O projeto pretende descentralizar a oferta de serviços assistenciais, tornando possível que regiões historicamente desassistidas disponham de unidades de saúde especializadas e modernizadas próximas ao domicílio dos cidadãos. Como resultado, os pacientes terão a possibilidade de realizar consultas, exames e tratamentos em suas próprias regiões, eliminando longos deslocamentos para grandes centros urbanos. Essa mudança proporcionará uma redução significativa na desigualdade de acesso, especialmente nas populações em situação de vulnerabilidade.
  (Alinhado aos OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade; OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais.)

- 1. 2. 40.

  **Melhoria da Qualidade e da Resolutividade do Atendimento:**
  Ao implantar linhas de cuidado e estabelecer protocolos clínicos unificados, o projeto fortalece a capacidade de diagnóstico precoce e o tratamento adequado das DCNTs e gestação de risco. A modernização dos equipamentos e a ampliação da infraestrutura permitirão que as condições clínicas sejam manejadas de forma mais eficaz, resultando em tratamentos mais rápidos e resolutivos. Essa melhoria eleva a qualidade do atendimento, e também diminui a ocorrência de complicações e internações evitáveis.
  (Alinhado aos OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade; OE 302 – Aperfeiçoar as capacidades estatais.)

- 1. 2. 41.

  **Fortalecimento da Governança e Integração Regional:**
  A realização de oficinas regionais visam promover a integração e a articulação entre gestores estaduais e municipais. Essa governança aprimorada permitirá a construção de planos de ação conjuntos e a definição de fluxos assistenciais claros, o que resultará em um sistema mais harmonioso e eficiente. A melhoria na coordenação reduzirá a fragmentação do cuidado, atuando de forma sinérgica para atender às demandas da população.
  (Alinhado aos OE 302 – Aperfeiçoar as capacidades estatais; OE 303 – Intensificar a transformação digital

nos três níveis de governo.)

- 1. 2. 42.

  **Adoção de Soluções Tecnológicas e Inovação Digital:**
  A implantação de ferramentas digitais, como prontuários eletrônicos e sistemas de telemedicina, possibilitará uma integração fluida entre unidades de saúde, agilizando o acesso a informações e permitindo consultas e diagnósticos remotos. Essa transformação digital facilitará o acompanhamento contínuo de pacientes, principalmente daqueles que sofrem de doenças crônicas, e reduzirá barreiras logísticas que historicamente dificultam a prestação de serviços em áreas remotas e para populações vulneráveis.
  (Alinhado aos OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade; OE 303 – Intensificar a transformação digital.)

- 1. 2. 43.

  **Redução dos Custos e Melhoria na Eficiência do Sistema:**
  Com a descentralização dos serviços e a oferta de atendimento especializado nas próprias regiões, o projeto reduzirá os custos operacionais e os gastos dos usuários/municípios relacionados ao transporte. Ao facilitar o acesso e melhorar a resolutividade do cuidado, o sistema se torna mais eficiente, permitindo que os recursos sejam aplicados de forma mais racional e direcionada. Essa economia permitirá investimentos contínuos e a melhoria gradual dos serviços prestados.
  (Alinhado aos OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade; OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais.)

- 1. 2. 44.

  **Expansão da Capacidade de Resposta a Doenças Crônicas e Condições Complexas:**
  A modernização e expansão da infraestrutura, associadas à implementação de linhas de cuidado e ao fortalecimento da capacitação das equipes, proporcionarão uma resposta mais efetiva aos desafios impostos por doenças crônicas e condições de alta complexidade. Essa ampliação da capacidade de resposta resultará em uma melhoria significativa na saúde da população, com reflexos diretos na redução da mortalidade e das complicações associadas às DCNTs e Gestações de Alto Risco.
  (Alinhado aos OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade; OE 302 – Aperfeiçoar as capacidades estatais.)

Em síntese, a implementação do projeto proporcionará um SUS mais equitativo, eficiente e integrado, capaz de responder às demandas regionais e às necessidades de suas populações. Os benefícios esperados, que vão desde a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento até a redução de custos e o fortalecimento da governança, representarão um salto qualitativo para a saúde pública em São Paulo, conforme as diretrizes dos Objetivos Estratégicos 102, 214, 302 e 303 do PPA 2024-2027.

1. 3. **Objetivo**

**(i) Objetivo Geral**

O Projeto tem o objetivo de consolidar e aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo, promovendo maior equidade, eficiência e integração na oferta de serviços de saúde.

**(ii) Objetivos Específicos**

*a) Fortalecer a governança regional e a integração assistencial por meio de oficinas, consultorias e implementação de protocolos de gestão que articulem gestores e equipes das RRAS, promovendo a padronização do cuidado.*

- 1. 4.

  Alinhamento:

  - 1. 5.

Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 302

- 1. 6.

  Componente/Subcomponente/Produto: Componente I / S.1.1 / P.1.1.1, P.1.1.2 e P.1.1.3

- 1. 7.

  Indicador: 1, 2, 8,10

*b) Modernizar a infraestrutura e atualizar o parque tecnológico das unidades de saúde com reformas, adequações físicas e aquisição de equipamentos modernos, ampliando a capacidade de atendimento local.*

- 1. 8.

  Alinhamento:

  - 1. 9.

    Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

  - 1. 10.

    Componente/Subcomponente/Produto: Componente II / S.2.1 / P.2.1.1, P.2.1.2, P.2.1.3 e P.2.1.4

  - 1. 11.

    Indicadores: 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10

*c) Implantar soluções digitais integradas, como prontuários eletrônicos e telemedicina, para otimizar a comunicação, a regulação e o atendimento remoto em todo o sistema de saúde.*

- 1. 12.

  Alinhamento:

  - 1. 13.

    Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 303

  - 1. 14.

    Componente/Subcomponente/Produto: Componente III / S.3.1 / P.3.1.1

  - 1. 15.

    Indicador: 5 e 7

*d) Construir novos hospitais em regiões prioritárias com alto Índice de Dependência Regional, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo deslocamentos e desigualdades no acesso.*

- 1. 16.

  Alinhamento:

  - 1. 17.

    Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

  - 1. 18.

    Componente/Subcomponente/Produto: Componente V / S.5.1 / P.5.1.1

- 1. 19.

  Indicadores: 1, 6 e 9.

1. 20. **Indicadores**

1. 20. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Índice de dependência Regional - IDR na Alta Complexidade na região de Itapetininga

**Descrição:**
Este indicador mensura a proporção de atendimentos de alta complexidade realizados por pacientes residentes da região de Itapetininga, fora de sua região, em relação ao total de atendimentos de alta complexidade na região de Itapetininga. A fórmula de cálculo é:

IDR = (Número de atendimentos de alta complexidade realizados por pacientes residentes da região de Itapetininga, fora de sua região / Número total de atendimentos de alta complexidade na região) x 100

Aplicando o modelo **SMART,** o indicador é:

- 1. 20. 2. **Específico:** focaliza os os atendimentos de alta complexidade realizados fora da àrea de residencia do paciente
- 1. 20. 3. **Mensurável:** quantifica o número de saídas da região
- 1. 20. 4. **Atingível:** considerando a construção do novo Hospital na região
- 1. 20. 5. **Relevante:** correlaciona diretamente com a melhoria do acesso
- 1. 20. 6. **Temporal:** com linha de base em 2023 de 95,53% e meta para 2031 de 80%.

Serão coletados dados dos registros do SIA/SIH/MS referentes aos atendimentos de alta complexidade.

Alinhamento:

- 1. 20. 7.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 8.

  Objetivo Específico: d) Construir novos hospitais em regiões prioritárias

- 1. 20. 9. Componente/Subcomponente/Produto: Componente V / S.5.1 / P.5.1.1

**Meta:**
Reduzir o IDR na Alta Complexidade de 95,53% em 2023 para 80% em 2031

1. 20. 10. **Informações do 2° indicador:**

**Nome:** Percentual de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica

**Descrição:**
Este indicador mensura a proporção de internações que poderiam ter sido evitadas por meio de uma atenção primária eficaz. Ele é calculado pela fórmula:

**Percentual** = (Número de internações por condições sensíveis à atenção básica / Total de internações) x 100

Utilizando o modelo **SMART,** o indicador é:

• Específico: focaliza as internações passíveis de prevenção por cuidados primários;

• Mensurável: expresso como percentual;

• Atingível: considerando as melhorias na integração e na resolubilidade do cuidado;

• Relevante: reflete a qualidade e a eficácia dos serviços de atenção primária;

• Temporal: com linha de base em 2024 (14,15%) e meta para 2031 (13%).

Serão coletados dados dos registros de internação do SIH/SUS.

**Alinhamento:**

- 1. 20. 11.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 12.

  Objetivo Específico: a) Fortalecer a governança regional e a integração assistencial

- 1. 20. 13.

  Componente/Subcomponente/Produto: Componente I / S.1.1 / P.1.1.1, P.1.1.2 e P.1.1.3

**Meta:**
**Reduzir o percentual de internações por condições sensíveis à atenção básica de 14,15% em 2025 para 13% até 2031**

1. 20. 14. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Número anual de atendimentos hospitalares realizados pela Rede Própria Estadual (Unidades da Adm. Direta, Gerenciadas por OSS e Autarquias

**Descrição:**
Este indicador mensura o total anual de atendimentos hospitalares realizados pela Rede Própria do Estado.

Através da soma dos atendimentos registrados (Internações clinicas e cirurgicas), em cada unidade ao longo do ano, poderemos observar o impacto das melhorias na infraestrutura e modernização dos Hospitais, ampliando sua capacidade assistencial. Baseado no modelo **SMART,** o indicador é:

• **Específico:** focaliza as unidades da Rede Estadual;

• **Mensurável:** quantifica o número total de atendimentos (internações), realizados anualmente;

• **Atingível:** considerando a modernização e expansão dos serviços;

• **Relevante:** correlaciona diretamente com a melhoria no acesso e na qualidade do atendimento;

• **Temporal:** utilizando uma linha de base definida para 2024 e meta para 2031.

Serão coletados dados anuais dos sistemas de informação do MS - SIH, contemplando o número total de internações realizados.

**Alinhamento:**

- 1. 20. 15.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 16.

  Objetivo Específico: b) Modernizar a infraestrutura e atualizar o parque tecnológico das unidades de saúde

- 1. 20. 17.

  Componente/Subcomponente/Produto: Componente II / S.2.1 / P.2.1.1, P.2.1.2, P.2.1.3 e P.2.1.4

**Meta:**
Aumentar em até 20% o número de internações nas Unidades da rede Própria do estado de SP, saindo de 988.107 internações registradas em 2024 para 1.185.728 até 2031

1. 20. 18. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Número anual de atendimentos especializados ambulatoriais realizados pela rede própria estadual (Unidades da Adm. Direta, Gerenciadas por OSS e Autarquias

**Descrição:**
Este indicador mensura o total anual de procedimentos ambulatoriais (Consultas médicas, Teleconsultas, exames com a presença do médico e cirurgias ambulatoriais), com exceção da dispensação de medicamentos, realizados pela Rede Própria do Estado - Ambulatorios Hospitalares e Ambulatórios Médicos de Especialidades - AMEs.

. Através da soma dos procedimentos registrados, em cada unidade ao longo do ano, poderemos observar o impacto das melhorias na infraestrutura e modernização das Unidades, ampliando sua capacitação assistencial. Baseado no modelo SMART, o indicador é:

• **Específico:** focaliza as unidades da Rede Estadual;

• **Mensurável:** quantifica o número total de atendimentos ambulatoriais, realizados anualmente;

• **Atingível:** considerando a modernização e expansão dos serviços;

• **Relevante:** correlaciona diretamente com a melhoria no acesso e na qualidade do atendimento;

• **Temporal:** utilizando uma linha de base definida para 2025 e meta para 2031.

Serão coletados dados anuais dos sistemas de informação SIA/SUS, contemplando o número total de procedimentos realizados.

**Alinhamento:**

- 1. 20. 19.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 20.

  Objetivo Específico: b) Modernizar a infraestrutura e atualizar o parque tecnológico das unidades de saúde

- 1. 20. 21.

  Componente/Subcomponente/Produto: Componente II / S.2.1 / P.2.1.1, P.2.1.2, P.2.1.3 e P.2.1.4

**Meta:**
Aumentar em 20% o número de atendimentos ambulatoriais nas Unidades da rede Própria do estado de SP, saindo de 19.451.219 atendimentos registrados em 2024 para 23.341.462 até 2031.

1. 20. 22. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Percentual de aumento dos teleatendimentos realizados nos Ambulatórios Médicos de Especialidades

**Descrição:**
Este indicador visa dimensionar a ampliação do acesso de saúde através de serviços digitais.

**Linha de base:** 2500 teleatendimentos até a fevereiro/2025

**Fórmula de cálculo (X 100):**

- Numerador: teleatendimentos realizados

- Denominador: teleatendimentos programados

**Fonte:** https://nies.saude.sp.gov.br/ses

**Meta:**
Anual do PPA (cálculo baseado nos teleatendimentos previstos no plano de trabalho do PDI): **8500 teleatendimentos**

1. 20. 23. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Média mensal de pacientes atendidos nos novos leitos instalados

**Descrição:**
Este indicador mensura a média mensal de pacientes atendidos nos novos leitos instalados na RRAS 8, decorrente do acréscimo de 225 leitos (de 2808 para 3033 na RRAS). A fórmula de cálculo é:

Média Mensal = (Total de pacientes atendidos em um mês nos novos leitos) / (Número de leitos novos instalados na Unidade, no período)

Com base no modelo **SMART,** o indicador é:

- 1. 20. 24. **específico:** focado nos novos leitos da RRAS 8
- 1. 20. 25. **mensurável:** quantifica o número de atendimentos mensais
- 1. 20. 26. **atingível:** considerando o potencial dos 225 leitos acrescidos
- 1. 20. 27. **relevante:** reflete a ampliação da capacidade assistencial em regiões prioritárias
- 1. 20. 28. **temporal:** linha de base em 2025 e meta para 2031.

Serão coletados mensalmente os dados referentes ao número de pacientes atendidos, ao número efetivo de leitos operacionais e à taxa de ocupação.

**Alinhamento:**

- 1. 20. 29.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 30.

  Objetivo Específico: d) Construir novos hospitais em regiões prioritárias

- 1. 20. 31.

  Componente/Subcomponente/Produto: Componente V / S.5.1 / P.5.1.1

**Meta:**
Alcançar uma média de 5 pacientes atendidos mensalmente por leito, nos novos leitos instalados na Unidade até 2031.

Linha de Base (2025): 0

Meta (2031): média mensal de 5 pacientes/leito nos novos leitos.

1. 20. 32. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Taxa de resolubilidade dos teleatendimentos realizados nos Ambulatórios Médicos de Especialidades

**Descrição:**

Este indicador visa o acompanhamento da resolubilidade dos casos realizados por teleatendimento.

Ampliar a taxa de resolubilidade gradualmente, até conseguir atingir 85% nos teleatendimentos realizados nos Ambulatórios Médicos de Especialidades.

**Linha de Base:** 75% de resolutividade em 2025

**Fórmula de cálculo (X 100):**

- Numerador: teleatendimentos resolvidos sem encaminhamento presencial;

- Denominador: total de teleatendimentos realizados.

**Fonte:** https://nies.saude.sp.gov.br/ses

**Meta:**
Atingir 85% de resolubilidade nos teleatendimentos realizados.

1. 20. 33. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Razão de mortalidade materna

**Descrição:**
A razão de mortalidade materna (RMM) é um indicador de saúde que mede o número de mortes relacionadas à gestação, parto e puerpério por 100mil nascidos vivos.

Este indicador mensura a razão de mortalidade materna no período de 1 ano. Ele é calculado pela fórmula:

óbitos maternos / 100 mil Nascidos vivos

Aplicando o modelo **SMART,** o indicador é:

- 1. 20. 34. **Específico:** focaliza o número de óbitos em parturientes
- 1. 20. 35. **Mensurável:** atingível, considerando a melhoria do acesso e a implantação das linhas de cuidado
- 1. 20. 36. **Relevante:** Correlacionado à diminuição de riscos no parto
- 1. 20. 37. **Temporal:** com linha de base em 2023 de 42,1 e meta para 2031 de 38

Serão coletados dados do Site DATASUS/MS/Estatísticas Vitais/òbitos Maternos e Nascidos Vivos.

**Alinhamento:**

Indicador chave nacional do OE 102

Objetivo Específico: a) Fortalecer a governança regional e a integração assistencial

Componente I/ S.1.1/P1.1.1, P1.1.2, P1.1.3 e

Componente II/ S.1.2/P.1.2.1,P1.2.2

**Meta:**
Diminuir esta razão de 42,1 para 38,0 até 2031

1. 20. 38. **Informações do 9° indicador:**
**Nome:** Índice de dependência Regional - IDR na Média Complexidade na região de Itapetininga

**Descrição:**
Este indicador mensura o percentual de atendimentos de média complexidade realizados por pacientes residerntes da região de Itapetininga, realizados fora de sua região. A fórmula de cálculo é:

IDR = (Número de atendimentos de média complexidade de pacientes residentes na região de Itapetininga, atendidos fora do domicilio / Número total de atendimentos de média complexidade de pacientes residentes da região de Itapetininga) x 100

Aplicando o modelo **SMART,** o indicador é:

- 1. 20. 39. **Específico:** focaliza os procedimentos realizados fora da àrea de residencia do paciente
- 1. 20. 40. **Mensurável:** quantifica o número de saídas da região
- 1. 20. 41. **Atingível:** considerando a construção do novo Hospital na região
- 1. 20. 42. **Relevante:** correlaciona diretamente com a melhoria do acesso
- 1. 20. 43. **Temporal:** com dados coletados a partir dos registros do SIA/MS. A linha de base está estabelecida em 24,60% em 2023.

**Alinhamento:**

- 1. 20. 44.

  Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102 e OE 214

- 1. 20. 45.

  Objetivo Específico: d) Construir novos hospitais em regiões prioritárias

- 1. 20. 46. Componente/Subcomponente/Produto: Componente IV

**Meta:**
Reduzir o IDR na Média Complexidade de 24,60% em 2023 para 18% em 2031

1. 20. 47. **Informações do 10° indicador:**
**Nome:** Mortalidade infantil

**Descrição:**
O Coeficiente de mortalidade infantil é um indicador de saúde e condições de vida de uma população. A taxa de mortalidade infantil é calculada para estimar o risco de um recém-nascido morrer antes de completar um ano de idade.

Este indicador mensura a taxa de mortalidade infantil no estado de São Paulo, através da fórmula:

óbitos de Crianças até 1 ano no período de 1 ano/ Nascidos vivos no mesmo período x 1.000

Aplicando o modelo **SMART,** o indicador é:

- 1. 20. 48. **Específico:** focaliza o número de óbitos em crianças até 1 ano
- 1. 20. 49. **Mensurável:** atingível, considerando a melhoria do acesso e a implantação das linhas de cuidado
- 1. 20. 50. **Relevante:** Correlacionado à diminuição de riscos de óbito infantil
- 1. 20. 51. **Temporal:** com linha de base em 2023 de 11,2 e meta para 2031 de 9,5

Serão coletados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e sobre Nascidos Vivos - SINASC/CIVS/CCD/SESSP

Alinhamento

Indicador chave nacional do OE 102

Objetivo específico: a) Fortalecer a governança regional e a integração assistencial

Componente I/ S.1.1/P1.1.1, P1.1.2, P1.1.3 e

Componente II/ S.1.2/P.1.2.1,P1.2.2

**Meta:**
Diminuir a tx atual de 11,2 para 9,5 até 2031

1. 21. **Componentes**

1. 21. 1. **Informações do 1° componente:**
**Nome:** APOIO À GESTÃO DO SUS EM SÃO PAULO COM ÊNFASE NOS PROCESSOS DE REGIONALIZAÇÃO
**Valor estimado em Real (BRL):** 45.920.000,00

**Descrição:**
Este componente visa fortalecer a capacidade gerencial e estratégica da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para promover a integração e a coordenação das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) em todo o Estado de São Paulo. Ele se propõe a responder aos desafios identificados no diagnóstico, como a fragmentação do cuidado, a desigualdade no acesso aos serviços e a necessidade de modernização dos processos de gestão assistencial.

**O componente é estruturado em dois subcomponentes principais:**

- 1. 21. 2.

  *SC.1.1 – Gestão de Redes e Governança:*
  Focado em aprimorar a articulação entre gestores e equipes das RRAS, este subcomponente busca criar condições para a definição de estratégias regionais integradas. Por meio de oficinas, consultorias e treinamentos, pretende-se desenvolver uma nova cultura de governança que possibilite a padronização do cuidado, a otimização dos recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, garantindo maior equidade no acesso.

- 1. 21. 3.

  *SC.1.2 – Implantação de Novos Modelos Assistenciais:*
  Este subcomponente tem como objetivo inovar na prestação de serviços de saúde, promovendo a educação permanente e a capacitação dos profissionais, om o intuito de melhorar a capacitação dos profissionais e a integração dos níveis de atenção. A intenção é implementar modelos assistenciais que se adaptem às necessidades locais, contribuindo para a melhoria dos processos de atendimento e para a consolidação de linhas de cuidado prioritárias. Essa ação busca integrar e otimizar a prestação de serviços em todos os níveis de atenção, garantindo uma resposta mais efetiva aos desafios regionais.

Ao fortalecer a governança e promover a integração dos processos de gestão, este componente contribui para reduzir a fragmentação do sistema, melhorar a alocação de recursos e ampliar a eficiência do SUS. Espera-se, com sua implementação, uma maior articulação entre os níveis de atenção, a padronização dos protocolos de atendimento e, consequentemente, a oferta de serviços de saúde mais equitativos e resolutivos para a população.

**Relação com o Problema e os Resultados Esperados:**
Este componente está diretamente alinhado à necessidade de enfrentar as desigualdades regionais e a fragmentação dos serviços de saúde. Ao aprimorar a gestão e a integração das RRAS, promove-se um ambiente onde os recursos são distribuídos de maneira mais eficiente, possibilitando a implementação de políticas assistenciais que priorizem a qualidade e o acesso equitativo, conforme os resultados esperados. Dessa forma, o componente sustenta a transformação do sistema de saúde estadual, preparando o terreno para melhorias significativas na prestação do atendimento.

**Alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PPA:**
Este componente está alinhado aos Objetivos Estratégicos do PPA, especialmente ao OE 102 (Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade) e ao OE 302 (Promover o aperfeiçoamento das capacidades estatais e o fortalecimento da cooperação federativa).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**O Componente 1 – Apoio à Gestão do SUS em São Paulo com Ênfase nos Processos de Regionalização** – está estruturado em dois subcomponentes, que englobam um conjunto de produtos voltados ao aprimoramento da governança e à implantação de novos modelos assistenciais:

**Subcomponente SC.1.1 – Gestão de Redes e Governança**

Este subcomponente tem como finalidade fortalecer a coordenação e a integração dos gestores das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), promovendo uma cultura de governança inovadora e colaborativa, buscando a padronização dos processos de gestão e o desenvolvimento de planos integrados, garantindo o acesso e a melhoria da qualidade dos serviços.

- 1. 21. 4.

  *Produto P.1.1.1 – Oficinas do Processo de Regionalização do SUS SP*
  Descrição: Realização de oficinas de trabalho que englobam consultorias e treinamentos, especialmente voltadas à Gestão Regional, com o objetivo de promover a redefinição do perfil assistencial das unidades que compõem as RRAS, incentivando a integração dos serviços e o compartilhamento de boas práticas, com a finalidade de equalizar o acesso e a qualidade dos serviços em todo o estado.
  Informações Quantitativas: Serão realizadas 34 sessões presenciais e/ou virtuais, distribuídas ao longo do período de implantação do projeto, envolvendo um número representativo de gestores e equipes regionais.

- 1. 21. 5.

  *Produto P.1.1.2 – Modelos de Governança Inovadores*
  Descrição: Prestação de consultoria especializada para o fortalecimento dos Comitês Executivos de Governança Regional, com foco em estabelecer e disseminar modelos de governança eficazes, visando promover a integração entre governo, prestadores de serviços e usuários, garantindo assim uma melhor disponibilidade de serviços e redução das lacunas existentes.
  Informações Quantitativas: A consultoria abrangerá a estruturação e o acompanhamento de reuniões periódicas dos 18 comitês, com indicadores qualitativos e quantitativos a serem definidos em termos de adesão e eficiência dos processos de tomada de decisão.

- 1. 21. 6.

  *Produto P.1.1.3 – Apoio Metodológico para o Desenvolvimento do Plano Regional Integrado (PRI)*
  Descrição: Fornecimento de consultoria para o apoio metodológico na elaboração dos Planos Regionais Integrados, aprimorando a organização da rede de saúde e a governança regional, por meio de metodologias que integrem as necessidades locais com as diretrizes estaduais.
  Informações Quantitativas: A ação incluirá o suporte técnico para a elaboração dos PRI em todas as RRAS, com prazos e metas definidos para a finalização dos planos em cada região.

**Subcomponente SC.1.2 – Implantação de Novos Modelos Assistenciais**

Este subcomponente visa inovar na prestação dos serviços de saúde por meio da implementação de estratégias de educação permanente e da consolidação de linhas de cuidado. A iniciativa tem como propósito aprimorar os processos assistenciais.

- 1. 21. 7.

  *Produto P.1.2.1 – Implementação do Plano Diretor de Educação Permanente para o SUS (PDEP)*
  Descrição: Realização de consultorias para apoio na implementação do PDEP, resgatando e fortalecendo o papel dos Centros Formadores (CEFOR) e dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação (CDQ), formando e capacitando profissionais para o desenvolvimento de projetos que promovam a qualificação da assistência e a melhoria contínua dos processos clínicos.
  Informações Quantitativas: A implementação do PDEP será mensurada pelo número de profissionais capacitados e pela quantidade de cursos e workshops realizados ao longo do projeto.

- 1. 21. 8.

  *Produto P.1.2.2 – Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no Processo de Regionalização*
  Descrição: Prestação de consultoria para apoio na implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias, com foco na adoção de protocolos diagnóstico-terapêuticos baseados em evidências, na humanização do atendimento e na redução de procedimentos desnecessários.
  Informações Quantitativas: A meta é implementar 5 linhas de cuidado em cada uma das 18 RRAS, monitorando a adesão aos protocolos e a melhoria dos processos de encaminhamento e continuidade do atendimento.

**Resumo e Conexão com os Resultados Esperados**

A implantação dos subcomponentes e produtos deste componente visa criar uma base robusta para a regionalização do SUS, resultando em uma melhoria significativa na governança, na integração dos serviços e na qualidade do atendimento em todo o Estado de São Paulo. As ações do Componente respondem diretamente à necessidade de superar a fragmentação dos serviços e as desigualdades regionais, contribuindo para a eficiência e a equidade do sistema de saúde.

Os resultados esperados, tais como a padronização do cuidado, a redução das lacunas assistenciais e a ampliação do acesso, serão mensurados por meio de indicadores qualitativos e quantitativos definidos para cada produto.

Essa abordagem integrada e quantitativa alinha o componente com os Objetivos Estratégicos do PPA – OE 102 e OE 302, assegurando que os esforços para a regionalização se traduzam em melhorias concretas e mensuráveis na prestação dos serviços de saúde.

1. 21. 9. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
**Valor estimado em Real (BRL):** 619.920.000,00

**Descrição:**
Este componente tem como finalidade modernizar e otimizar a infraestrutura das unidades de saúde da SES envolvidas no projeto ARAS, abrangendo as RRAS 1 a 6 e RRAS 8. Sua proposta é atender às deficiências identificadas no diagnóstico realizado no processo da revisão da regionalização no estado, especialmente no que diz respeito à infraestrutura física defasada e à obsolescência do parque tecnológico, que comprometem a capacidade de atendimento e por consequência, a eficiência e a resolutividade em saúde.

Ao investir na atualização das instalações e na incorporação de novas tecnologias, este componente busca:

- 1. 21. 10.

  **Melhorar a qualidade dos serviços assistenciais:** Ao modernizar as unidades, o projeto visa reduzir barreiras físicas e tecnológicas que impedem a realização de procedimentos de média e alta complexidade em maior número, contribuindo para a melhoria dos resultados assistenciais e a redução dos tempos de espera.

- 1. 21. 11.

  **Descentralizar e ampliar o acesso:** A modernização das estruturas permitirá a expansão da capacidade de atendimento em regiões historicamente desassistidas, promovendo a equidade no acesso aos serviços de saúde e reduzindo a necessidade de deslocamentos para centros de referência.

- 1. 21. 12.

  **Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos:** Com instalações atualizadas e equipadas com tecnologias modernas, os hospitais poderão operar de forma mais eficiente, otimizando o uso de recursos e melhorando a sustentabilidade do sistema.

- 1. 21. 13.

  **Preparar as unidades para futuros desafios:** A adequação das estruturas incluirá aspectos de resiliência, visando garantir que as unidades de saúde estejam preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos e outros desastres, assegurando a continuidade do atendimento mesmo em situações adversas.

Este componente está diretamente alinhado à solução proposta para combater as desigualdades regionais e a defasagem assistencial, contribuindo para a consolidação de um SUS mais moderno, eficiente e equitativo.

Seus resultados esperados incluem a ampliação da capacidade de atendimento, a melhoria da qualidade dos serviços e a redução das iniquidades, alinhando-se aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 102 (Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade) e OE 214 (Reduzir as desigualdades regionais).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

**Componente 2: Infraestrutura e Atualização do Parque Tecnológico**

O Componente 2 do Programa tem como objetivo modernizar as instalações e atualizar o parque tecnológico das unidades da SES envolvidas no projeto ARAS, abrangendo as RRAS 1 a 6, RRAS 8. Este componente é fundamental para corrigir a defasagem da infraestrutura e garantir que os hospitais operem com condições adequadas para oferecer serviços de média e alta complexidade, bem como para enfrentar eventos climáticos extremos e outras contingências.

**Subcomponente SC.2.1 – Melhorias na Infraestrutura da Rede de Serviços Estaduais**

Este subcomponente concentra os investimentos necessários para realizar a adequação física e a modernização dos hospitais da rede própria do estado A partir deste esforço, espera-se melhorar a qualidade dos ambientes assistenciais, aumentar a capacidade operacional e otimizar o uso dos recursos públicos, contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados assistenciais.

Descrição Detalhada dos Produtos:

- 1. 21. 14.

  *Produto P.2.1.1 – Adequação Física dos Hospitais da Rede Própria do Estado:*
  Este produto contempla a realização de reformas estruturais em 21 hospitais administrados diretamente pela SES. As intervenções incluirão melhorias nas instalações físicas, como modernização dos espaços de atendimento, adequação dos acessos para pessoas com deficiência, e atualização das áreas de espera e atendimento. Essas reformas visam proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e eficiente para os pacientes e profissionais, contribuindo para a redução de riscos e a melhoria da experiência assistencial.

- 1. 21. 15.

  *Produto P.2.1.2 – Modernização dos Hospitais Próprios do Estado:*
  Este produto prevê a aquisição e instalação de equipamentos tecnológicos de ponta em 7 hospitais da administração direta. Entre os investimentos, incluem-se equipamentos para diagnóstico por imagem (como tomógrafos, ressonâncias magnéticas e aparelhos de ultrassom), sistemas laboratoriais modernos e equipamentos para suporte terapêutico. A modernização tecnológica possibilitará diagnósticos mais precisos, agilizando o processo assistencial e aumentando a capacidade de realizar procedimentos de média e alta complexidade dentro dos próprios hospitais.

**Alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PPA:**

- 1. 21. 16.

  OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade: Ao modernizar as instalações e ampliar a capacidade assistencial, o componente contribui para oferecer serviços de qualidade de forma mais abrangente e equitativa.

- 1. 21. 17.

  OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais: A descentralização dos serviços, por meio da modernização das unidades em regiões prioritárias, promove um acesso mais igualitário à saúde em todo o estado.

Em resumo, o Componente 2 – Infraestrutura e Atualização do Parque Tecnológico – estabelece uma base sólida para a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados pelas unidades da SES, por meio da adequação física e da modernização tecnológica. Essa iniciativa não só atende às necessidades imediatas de infraestrutura, mas também contribui para resultados assistenciais mensuráveis, alinhados com as metas de equidade e eficiência do projeto.

1. 21. 18. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** SAÚDE DIGITAL
**Valor estimado em Real (BRL):** 172.200.000,00

**Descrição:**
O Componente 3, Inovação Digital - Saúde Digital, tem como objetivo, construir modelos de serviços de saúde embasados por tecnologia da informação e comunicação (TIC) nos três níveis de atenção assistencial promovendo ampliação de acesso, mitigação de desigualdades e integralidade do cuidado.

Planejando a estruturação das Unidades da Rede Própria da SES com equipamentos de TI avançados, de forma a promover a implantação de soluções de telessaúde, tecnologias POC (Point of Care) e a informatização integral das unidades, fortalecendo a análise de grandes bancos de dados para a gestão populacional de saúde.

Ao modernizar a infraestrutura digital, o componente responde a desafios identificados no diagnóstico, tais como a fragmentação dos sistemas de informação, a ineficiência na comunicação entre os diferentes níveis de atenção e a necessidade de uma regulação mais ágil dos serviços. Dessa forma, a integração digital pretende:

- otimizar a comunicação e a regulação entre as unidades de saúde, permitindo uma troca de informações mais rápida e precisa, o que se traduz em diagnósticos mais céleres e decisões baseadas em dados;

- ampliar o acesso aos serviços de saúde remotos, por meio da telessaúde, facilitando o atendimento de pacientes em áreas distantes e contribuindo para a descentralização do cuidado;

- fortalecer a gestão populacional por meio da consolidação de análises de grandes bancos de dados, possibilitando o acompanhamento efetivo dos indicadores epidemiológicos e o monitoramento contínuo dos programas e políticas de saúde.

Os resultados esperados incluem a agilização dos processos assistenciais, a redução dos erros de comunicação e uma maior capacidade de resposta às demandas populacionais, com impacto positivo na qualidade dos serviços prestados.

**Alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PPA:**

- **Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 da União**

Programa: Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde

Objetivos Específicos (são 8), selecionamos:

OE 367: ampliar a oferta de atendimentos realizados por meio de telessaúde no âmbito do SUS em território nacional;

OE 386: ampliar as ações para o fortalecimento da gestão do trabalho na saúde;

OE 364: ampliar o acesso a informações de saúde e serviços digitais aos gestores, profissionais e cidadãos;

- **Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado**

Programa 947: Tecnologia da Informação, Comunicação e Inovação em Saúde Digital.

Produtos (são 5), selecionamos:

2356: Infraestrutura tecnológica atualizada, expandida e modernizada;

2366: Atendimento remoto à saúde em ambulatórios médicos de especialidades - TeleAME;

2368: Atendimento remoto à atenção primária à saúde - TeleAPS.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Os subcomponentes contemplados são:**

**SC 3.1 - Melhoria da Tecnologia em Saúde, que abrange os produtos:**

- P 3.1.1 - Melhoria da Infraestrutura de Tecnologia em Saúde nos Hospitais;

- P 3.1.2 - Implantação dos Equipamentos de Tecnologia em Saúde na SES.

**SC 3.2 - Ampliar a oferta de atendimentos realizados por meio da telessaúde no âmbito do SUS no Estado, que abrange os produtos:**

- P 3.2.1 Implantação e operacionalização do Centro Líder em saúde digital para coordenar e impulsionar as iniciativas em todo o Estado de São Paulo;

- P 3.2.2. AME Digital - Teleatendimento TeleAME.

1. 21. 19. **Informações do 4° componente:**
**Nome:** CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL (Contrapartida)
**Valor estimado em Real (BRL):** 215.250.000,00

**Descrição:**
Este componente tem como finalidade construir um novo Hospital Geral Regional nas RRAS 8, com foco na região de Itapetininga, para suprir a carência de serviços assistenciais identificada durante o diagnóstico do processo de regionalização. O objetivo é oferecer uma solução estrutural para a concentração dos serviços em grandes centros, que atualmente força pacientes a realizarem longos deslocamentos, comprometendo o acesso e a continuidade do cuidado, sobretudo para condições crônicas e de alta complexidade.

A implantação deste novo hospital proporcionará:

- 1. 21. 20.

  Melhoria no acesso e na qualidade do atendimento: Ao reduzir a necessidade de deslocamento para centros de referência, o hospital promoverá um atendimento mais ágil e próximo da população, garantindo que pacientes em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços especializados de forma eficiente.

- 1. 21. 21.

  Descentralização dos serviços de saúde: A nova unidade contribuirá para a descentralização do sistema assistencial, aliviando a sobrecarga dos hospitais já existentes e ampliando a oferta de cuidados na região.

- 1. 21. 22.

  Otimização do uso dos recursos públicos: Com infraestrutura moderna e adequada, o hospital possibilitará a realização de diagnósticos e tratamentos de média e alta complexidade, promovendo a eficiência operacional e a sustentabilidade do sistema de saúde, além de preparar a rede para responder a desafios decorrentes de eventos climáticos extremos.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PPA:

- 1. 21. 23.

  OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade: O novo hospital ampliará a capacidade de atendimento e reduzirá as barreiras de acesso aos serviços de saúde.

- 1. 21. 24. OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais: A construção da unidade em Itapetininga permitirá que regiões historicamente desassistidas tenham acesso a cuidados especializados, promovendo maior equidade no sistema.
- 1. 21. 25.

Este componente está, assim, diretamente vinculado à solução dos problemas de concentração de serviços e deslocamentos longos, contribuindo para resultados esperados que incluem a ampliação da oferta assistencial, melhoria dos indicadores de qualidade e eficiência no atendimento, e uma rede de saúde mais descentralizada e equitativa.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
Produto P 4.1 – Hospital Geral Regional na RRAS 8

Construir 1 novo Hospital Geral Regional na região de Itapetininga, nas RRAS 8, com o objetivo de suprir a carência assistencial identificada no processo de regionalização. Este hospital será desenvolvido para agilizar o atendimento, especialmente para pacientes com condições crônicas e de alta complexidade, reduzindo deslocamentos e sobrecarga em centros de referência. A nova unidade contará com infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, ampliando a oferta de leitos e serviços especializados para atender de forma eficiente a população local.

- 1. 21. 26.

  **Informações Objetivas e Quantitativas:**

  - 1. 21. 27.

    Implantação de 1 novo hospital na RRAS 8.

  - 1. 21. 28.

    Planejamento para ampliar a capacidade de atendimento, com incremento de leitos e ampliação dos serviços de média e alta complexidade, conforme diagnóstico regional.

  - 1. 21. 29. Foco na otimização do tempo de atendimento e na redução das barreiras de acesso para pacientes com condições crônicas.
- 1. 21. 30.

  **Relação com a Solução Proposta e Resultados Esperados:**
  Este produto responde à necessidade de descentralização dos serviços assistenciais, oferecendo uma estrutura que possibilite atendimento de qualidade próximo ao domicílio dos usuários. Espera-se que o novo hospital contribua para:

  - 1. 21. 31.

    Reduzir os deslocamentos dos pacientes e os custos associados, promovendo maior equidade no acesso.

  - 1. 21. 32.

    Melhorar os indicadores de atendimento assistencial, com maior rapidez e eficiência nos diagnósticos e tratamentos.

  - 1. 21. 33.

    Aumentar a capacidade operacional da rede, fortalecendo a integração e a qualidade dos serviços prestados.

- 1. 21. 34.

  **Alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PPA:**

  - 1. 21. 35.

    OE 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade.

  - 1. 21. 36. OE 214: Reduzir as desigualdades regionais.

1. 21. 37. **Informações do 5° componente:**
**Nome:** GESTÃO DO PROGRAMA
**Valor estimado em Real (BRL):** 22.960.000,00

**Descrição:**
Este componente tem como finalidade garantir a execução eficiente, integrada e transparente de todas as ações previstas no projeto, por meio de uma estrutura robusta de gerenciamento e supervisão. Para responder aos desafios identificados – tais como a complexidade da coordenação entre múltiplos órgãos e a necessidade de conformidade técnica, administrativa e financeira – este componente centraliza a gestão do projeto em uma Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), que atuará como núcleo de integração entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), as Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS e demais parceiros envolvidos.

**A UCP será responsável por:**

- 1. 21. 38.

  ***Coordenação e Integração:*** Organizar e harmonizar as ações entre os diversos atores, garantindo que as metas e prazos sejam cumpridos e que as intervenções estejam alinhadas com os objetivos do projeto.

- 1. 21. 39.

  ***Monitoramento e Avaliação:*** Implantar sistemas de acompanhamento e controle, com indicadores de desempenho e prestação de contas periódicas, para assegurar a efetividade das ações e a correta aplicação dos recursos.

- 1. 21. 40.

  ***Gestão Documental e Administrativa:*** Preparar e gerenciar processos licitatórios, elaborar relatórios técnicos, jurídicos e financeiros, e acompanhar a liquidação de despesas, de forma a garantir a conformidade com os padrões e exigências estabelecidos.

- 1. 21. 41.

  ***Suporte à Sustentabilidade:*** Assegurar que as ações implementadas se mantenham operacionais e eficazes após a conclusão do projeto, promovendo a continuidade dos serviços e a transferência de conhecimento para os órgãos gestoras.

Esse componente é crucial para solucionar problemas de fragmentação e ineficiência na gestão do projeto, pois, por meio de uma coordenação centralizada, busca integrar as iniciativas, otimizar o uso dos recursos e assegurar que os resultados esperados – como melhoria da qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos e transparência na execução – sejam efetivamente alcançados. Em resumo, a gestão do programa sustenta toda a estrutura do projeto, possibilitando que os avanços assistenciais e as inovações implantadas se consolidem de forma duradoura.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
Este componente está dividido em três produtos essenciais, que juntos compõem a oferta de bens e serviços para a gestão e supervisão do projeto:

- 1. 21. 42.

  **(P) Supervisão Técnica, Ambiental e Social:**

  - 1. 21. 43.

    Descrição: Este produto visa assegurar a fiscalização rigorosa das obras e intervenções implementadas no projeto, garantindo que todas as ações sejam executadas conforme os projetos aprovados e em conformidade com as normativas técnicas, ambientais e sociais vigentes.

  - 1. 21. 44.

Informações Objetivas:

- 1. 21. 45.

  Realização de monitoramento contínuo das obras e intervenções.

- 1. 21. 46.

  Implementação de medidas que assegurem a conformidade ambiental, incluindo a verificação de práticas sustentáveis e a adoção de métodos construtivos resilientes, como a certificação LEED para os equipamentos e instalações.

- 1. 21. 47.

  **(P) Apoio ao Gerenciamento do Projeto:**

  - 1. 21. 48.

    Descrição: Este produto compreende os serviços de suporte operacional e administrativo fornecidos pela Unidade Executora do Programa. Ele é responsável por coordenar a execução de todas as atividades do projeto, incluindo a elaboração de editais, a gestão de processos licitatórios, a produção de relatórios de acompanhamento e a administração da documentação técnica, jurídica e financeira.

  - 1. 21. 49.

    Informações Objetivas:

    - 1. 21. 50.

      Coordenação centralizada das atividades e integração entre os órgãos envolvidos.

    - 1. 21. 51.

      Produção de relatórios periódicos de monitoramento e avaliação, garantindo o acompanhamento dos prazos e a transparência na aplicação dos recursos.

    - 1. 21. 52.

      Responsabilidade pela fase de liquidação de despesas, assegurando que os serviços e produtos entregues estejam em conformidade com os contratos estabelecidos.

- 1. 21. 53.

  **(P) Auditoria Externa:**

  - 1. 21. 54.

    Descrição: Este produto prevê a contratação de uma empresa especializada para a realização de auditorias periódicas, com o objetivo de verificar a conformidade técnica, administrativa e financeira de todas as ações do projeto.

  - 1. 21. 55.

    Informações Objetivas:

- 1. 21. 56.

  Realização de auditorias em intervalos predefinidos (por exemplo, nos anos II, III, IV e V de execução).

- 1. 21. 57.

  Elaboração de relatórios de auditoria que identifiquem eventuais desvios, permitindo a implementação de medidas corretivas para assegurar a integridade e a transparência do projeto.

Esses três produtos compõem o pilar de gestão do projeto, fornecendo os instrumentos necessários para a coordenação integrada, o monitoramento eficaz e a garantia de qualidade na execução do programa. Juntos, eles suportam a estratégia de fortalecimento da gestão, contribuindo para a consolidação de um sistema de saúde mais eficiente, sustentável e orientado para resultados, alinhado com os objetivos gerais do projeto e com os critérios estabelecidos para a Avaliação SEAID.

## 1. 22. **Beneficiários**

Os beneficiários deste projeto compreendem os setores da população do Estado de São Paulo que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS), estimados em cerca de 27 milhões de pessoas – aproximadamente 60% da população estadual. Esses grupos são priorizados devido às suas condições socioeconômicas vulneráveis e às carências identificadas no acesso a serviços de saúde de qualidade.

**Características e Quantitativo:**

- 1. 23.

  **População de Baixa Renda:** A grande maioria dos beneficiários é composta por indivíduos e famílias com renda domiciliar per capita significativamente baixa. Essa parcela da população tem enfrentado um agravamento das condições socioeconômicas, sobretudo em decorrência de crises econômicas e sanitárias recentes, o que torna o acesso a serviços de saúde um desafio adicional.

- 1. 24.

  **Grupos Historicamente Marginalizados:** Entre os beneficiários, destacam-se mulheres – com ênfase nas mulheres negras –, comunidades quilombolas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade. Esses grupos, historicamente marginalizados, possuem acesso restrito a serviços especializados e enfrentam barreiras estruturais que limitam a continuidade do cuidado, o que acarreta maiores índices de morbidade e mortalidade.

- 1. 25.

  **Regiões Assistencialmente Desfavorecidas:** Uma parte significativa dos beneficiários reside em áreas onde a oferta de serviços de média e alta complexidade é insuficiente, como nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva e nas áreas abrangidas pela RRAS 8. Nessas regiões, a concentração dos serviços em grandes centros urbanos força longos deslocamentos, atrasos no atendimento e sobrecarga das unidades de referência, prejudicando a qualidade e a eficácia dos cuidados prestados.

**Condições Socioeconômicas e Carências:**

- 1. 26.

**Vulnerabilidade Socioeconômica:** Os beneficiários, especialmente aqueles em situação de extrema pobreza, dependem intensamente do SUS para o acesso a serviços de saúde essenciais. Essa vulnerabilidade é acentuada pela baixa escolaridade, falta de oportunidades de emprego e condições precárias de habitação, que, em conjunto, comprometem a qualidade de vida e a capacidade de enfrentar agravos de saúde.

- 1. 27.

**Barreiras de Acesso e Fragmentação dos Serviços:** As dificuldades de acesso estão diretamente relacionadas à carência de unidades de saúde em determinadas regiões, à ausência de infraestrutura adequada e à fragmentação dos serviços de saúde. Esses fatores impedem um atendimento integral e contínuo, especialmente para pacientes com condições crônicas que demandam acompanhamento regular e intervenções precisas.

- 1. 28.

**Desigualdades Regionais:** A concentração dos serviços de saúde em grandes centros urbanos gera disparidades regionais significativas, onde áreas periféricas ou de menor desenvolvimento não dispõem de recursos suficientes para atender a demanda local. Isso resulta em longos deslocamentos, custos adicionais para as famílias e, muitas vezes, em atrasos críticos no diagnóstico e tratamento.

**Impacto Esperado do Projeto:**
Ao melhorar a infraestrutura, descentralizar os serviços e fortalecer a gestão e a integração dos processos assistenciais, o projeto visa reduzir essas desigualdades e barreiras. A ampliação da rede de atendimento e a modernização dos sistemas garantem que os 27 milhões de beneficiários tenham acesso a cuidados de qualidade, mais próximos de suas residências, e que as condições socioeconômicas vulneráveis sejam mitigadas por meio de políticas públicas que promovam a equidade e a inclusão social.

Dessa forma, o projeto não só transforma a prestação de serviços de saúde, mas também contribui para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, elevando a qualidade de vida dos cidadãos que dependem do SUS em um estado de ampla diversidade e complexidade.

1. 29. **Anexos**

ANEXOS PROJETO

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

Este projeto é exclusivamente destinado ao atendimento da prioridade **"IV – Saúde: Atenção Primária e Especializada"**, conforme estabelecido no art. 15, § 3º, IV, da Resolução Normativa Nº 1, de 22 de novembro de 2024. No âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, as intervenções propostas se alinham diretamente a quatro Objetivos Estratégicos, promovendo avanços estruturais e sustentáveis na área de saúde. A seguir, apresentamos como o projeto contribui para cada um desses objetivos, relacionando-os com o "Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica" classificados em A, B, C, D, E, com base nos critérios do Anexo II da Resolução Normativa nº 1 supracitada.

**1. Objetivo Estratégico 102** – *Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade*

**Contribuição do Projeto:**

- 2. 2.

  Moderniza unidades de saúde e amplia a oferta de serviços especializados em regiões vulneráveis.

- 2. 3.

  Reduz deslocamentos, garantindo atendimento mais próximo ao usuário.

- 2. 4.

  Integra níveis de atenção com novas tecnologias e qualificações.

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: Nível A

- 2. 5.

  **Justificativa:**

  - 2. 6.

    Objetivo geral e objetivos específicos: Alinhados diretamente à ampliação do acesso, evidenciando clara intenção de transformar a oferta de serviços de saúde em todo o estado.

  - 2. 7.

    Indicadores SMART e metas viáveis: Há definição de indicadores (por exemplo, número anual de atendimentos e tempo de espera para procedimentos) que permitem verificar o cumprimento efetivo das metas.

  - 2. 8.

    Alocação de recursos significativa: Grande parte do orçamento destinado ao reforço da capacidade instalada, resultando em impactos estruturantes e com alto potencial de replicabilidade.

**2. Objetivo Estratégico 214** – *Reduzir as desigualdades regionais*

**Contribuição do Projeto:**

- 2. 9.

  Constrói novas unidades em áreas prioritárias, descentralizando a prestação de serviços.

- 2. 10.

  Foca em localidades historicamente desassistidas, promovendo equidade no acesso.

- 2. 11.

Fortalece a coordenação regional e a oferta de cuidados especializados.

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: Nível A

- 2. 12.

**Justificativa:**

- 2. 13.

  Objetivos específicos direcionados à redução das disparidades: Metas claras de descentralização e melhoria de infraestrutura, com forte evidência de impacto na qualidade e na proximidade do atendimento.

- 2. 14.

  Impacto estrutural e de longo prazo: As ações visam criar condições permanentes para a oferta de serviços especializados, transformando a dinâmica do acesso e diminuindo de forma sustentável a desigualdade regional.

- 2. 15.

  Alto potencial de replicabilidade: As mesmas soluções de modernização (reforma, aquisição de equipamentos e novos processos de governança) podem ser aplicadas a outras regiões em situação semelhante.

**3. Objetivo Estratégico 302** – *Promover o aperfeiçoamento das capacidades estatais e o fortalecimento da cooperação federativa*

**Contribuição do Projeto:**

- 2. 16.

  Oferece capacitação e criação de estruturas de coordenação, melhorando a governança.

- 2. 17.

  Integra esforços das Secretarias de Saúde estaduais e municipais, otimizando recursos e processos.

- 2. 18.

  Amplia a transparência e a efetividade na condução das políticas de saúde.

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: Nível B

- 2. 19.

**Justificativa:**

- 2. 20.

  Objetivos específicos e indicadores relacionados à governança: Há metas de gestão (como a periodicidade de reuniões, implementação de protocolos e indicadores de desempenho) que demonstram a viabilidade do fortalecimento institucional.

- 2. 21.

  Impacto complementar: Embora a gestão seja essencial para o sucesso das iniciativas de acesso e redução das desigualdades, seu potencial de impacto transformador ocorre principalmente como suporte ao cumprimento dos outros objetivos (OE 102 e OE 214).

- 2. 22.

Allocation of Resources: Uma parcela menor do orçamento é voltada especificamente para a melhoria da governança, mas ainda assim significativa para promover cooperação e eficiência.

**4. Objetivo Estratégico 303** – *Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo*

**Contribuição do Projeto:**

- 2. 23.

  Implanta prontuários eletrônicos, telemedicina e plataformas de análise de dados.

- 2. 24.

  Facilita a comunicação em tempo real e a tomada de decisão baseada em evidências.

- 2. 25.

  Viabiliza consultas remotas e padroniza informações clínicas, tornando o sistema mais ágil.

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: Nível B

- 2. 26.

  **Justificativa:**

  - 2. 27.

    Indicadores e metas definidos: O projeto estabelece prazos e metas SMART para implantação dos sistemas (por exemplo, porcentagem de unidades informatizadas e número de teleconsultas realizadas), demonstrando viabilidade.

  - 2. 28.

    Efeito complementar ao acesso e à gestão: A transformação digital, embora possua um impacto relevante na agilidade e eficiência, funciona em sinergia com as melhorias de infraestrutura e a descentralização, potencializando seus resultados.

  - 2. 29.

    Recursos e escalabilidade: Os investimentos em tecnologia são significativos e passíveis de escalonamento para outras regiões e para diferentes níveis de governo.

2. 30. **Anexos**

Sem anexos.

# 3. GESTÃO

## 3. 1. Arranjo institucional

### 3. 1. 1. Descrição:

O projeto será executado e coordenado exclusivamente pela **Secretaria de Estado da Saúde (SES)**, por meio de uma **Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)** vinculada diretamente ao **Gabinete do Secretário (GS)**. Esta UCP será responsável pelo gerenciamento global das ações, pelo acompanhamento das atividades e pelo monitoramento do andamento do projeto, incluindo a gestão técnica, administrativa e financeira.

Embora não envolva oficialmente outros órgãos na execução direta, o projeto contará com a participação indireta de diversos atores, que desempenharão papéis relevantes no cumprimento das metas:

3. 1. 1. 1.

**Departamentos Regionais de Saúde (DRS) da Secretaria de Estado da Saúde/SP**

- 3. 1. 1. 2.

  Papel Institucional: Assumem a coordenação e a execução de determinadas ações no âmbito regional, articulando as atividades entre municípios e serviços de saúde locais. Também apoiam na supervisão, avaliação e na coleta de dados referentes aos indicadores previstos pelo projeto.

3. 1. 1. 3.

**COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde)**

- 3. 1. 1. 4.

  Papel Institucional: Participa das discussões e deliberações sobre o processo de Regionalização, contribuindo para o planejamento e o alinhamento das políticas de saúde entre o Estado e os municípios. Colabora, ainda, no acompanhamento do andamento das ações e nas tomadas de decisão que envolvem pactuações regionais.

3. 1. 1. 5.

**Secretarias Municipais de Saúde**

- 3. 1. 1. 6.

  Papel Institucional: Atuam na implementação das atividades do projeto em nível local, garantindo a adequação das ações às necessidades específicas da população. Colaboram com a SES e os DRS na organização dos serviços, na alocação de recursos e na supervisão das equipes de atenção primária e especializada.

3. 1. 1. 7.

**Prestadores de Serviços de Saúde (SUS)**

- 3. 1. 1. 8.

  Papel Institucional: Unidades próprias, filantrópicas ou contratualizadas com o SUS, que participarão da expansão e qualificação da rede de atendimento. Esses prestadores devem adequar-se às diretrizes do projeto, assegurando a oferta de serviços em consonância com as metas de melhoria de acesso e qualidade.

A seguir, apresenta-se o arranjo institucional do Programa ARAS, evidenciando as linhas de comunicação e responsabilidades no âmbito do projeto:

- 3. 1. 1. 9.

  A ***SES,*** por meio da ***UCP***, centraliza o gerenciamento, o acompanhamento e a prestação de contas do projeto.

- 3. 1. 1. 10.

  Os ***DRS*** desempenham o papel de coordenação regional, interagindo com os municípios e serviços locais para operacionalizar as ações definidas.

- 3. 1. 1. 11.

  As ***Secretarias Municipais de Saúde*** implantam as ações em nível local, ajustando-as às realidades e demandas específicas de cada território.

- 3. 1. 1. 12.

  O ***COSEMS*** facilita a articulação entre os gestores municipais e o Estado, fomentando o diálogo e o alinhamento das decisões relativas ao processo de Regionalização.

- 3. 1. 1. 13. Os ***Prestadores de Serviços de Saúde*** são responsáveis por efetivar a oferta de serviços na rede, atuando sob orientação da SES e dos municípios no cumprimento dos objetivos de melhoria de acesso, qualidade e eficiência dos atendimentos.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
**Órgão principal:** Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
**Órgãos parceiros:**

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) possui sólida experiência na coordenação de programas de grande porte, inclusive financiados por organismos internacionais, o que lhe confere capacidade técnica e gerencial para executar o presente projeto. A pasta conta com equipe profissional composta por especialistas em gestão, saúde, finanças, licitações e outras áreas correlatas, com vivência comprovada em programas estratégicos e ações complexas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Qualificação e Experiência da Equipe Técnica**

- 3. 1. 4.

  ***Experiências Anteriores:*** A SES/SP já implementou com êxito o Programa de Fortalecimento da Gestão na Saúde (2014-2021), financiado por organismo internacional, o BID, o que evidencia o domínio de políticas de aquisição, a observância de salvaguardas socioambientais e a conformidade com padrões de monitoramento e avaliação de resultados.

- 3. 1. 5.

  ***Compromisso com o Projeto:*** As equipes responsáveis por planejamento, compras, controle financeiro e gestão de projetos serão alocadas para este programa, contando com consultorias específicas, quando necessário, para reforçar áreas técnicas e de avaliação.

- 3. 1. 6.

  ***Apoio Institucional Interno:*** A Secretaria mantém aproximadamente 70 mil servidores ativos, distribuídos em todas as regiões do Estado, possibilitando a mobilização de profissionais qualificados e com experiência nos diferentes níveis de atenção e segmentos da saúde.

**Recursos e Estruturas Disponíveis**

- 3. 1. 7.

  ***Organização por Departamentos Regionais de Saúde (DRS):*** Cada DRS tem estrutura instalada para apoiar a execução do projeto em nível regional, facilitando o planejamento, a coordenação das ações e a supervisão dos indicadores de desempenho.

- 3. 1. 8.

  ***Conhecimento das Políticas do BID:*** A SES/SP tem familiaridade com as normas de aquisição e salvaguardas socioambientais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), assegurando a conformidade dos processos licitatórios e a adoção de padrões internacionais de qualidade.

- 3. 1. 9.

  ***Infraestrutura Administrativa e Logística:*** A Secretaria dispõe de sistemas informatizados de compras, contabilidade, monitoramento e controle, além de ambientes físicos adequados no Gabinete do Secretário (GS) e nos órgãos centrais para a realização de oficinas, reuniões e capacitações.

**Repasse de Recursos:**

De acordo com o desenho institucional definido para este projeto, não se prevê repasse direto de recursos financeiros a outras instituições. A execução orçamentária e financeira permanecerá sob a responsabilidade única da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP). Essa centralização permite maior controle e transparência na aplicação dos recursos, garantindo que as ações sejam implementadas conforme o planejamento estabelecido e o escopo aprovado.

Em síntese, a SES/SP dispõe de condições técnicas, gerenciais e logísticas para conduzir o projeto de forma efetiva e transparente, contando com equipes especializadas, procedimentos consolidados de execução financeira e um arcabouço institucional que respalda a implementação das ações em todas as regiões do Estado.

3. 1. 10. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo - Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para garantir a continuidade das ações propostas e assegurar a manutenção dos produtos e serviços implementados após a conclusão do projeto, serão adotadas estratégias e medidas integradas, contemplando tanto aspectos operacionais quanto financeiros. Essas ações visam assegurar que as melhorias estruturais, tecnológicas e de gestão sejam sustentadas a longo prazo, mantendo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pelo SUS no Estado de São Paulo.

**Estratégias de Operacionalização e Manutenção:**

3. 2. 1.

***Planejamento e Integração Orçamentária:***

- 3. 2. 2.

As despesas correntes decorrentes da manutenção das obras, equipamentos e serviços implementados serão previstas e integradas na programação orçamentária da SES/SP, por meio do PPA e da Lei Orçamentária Anual.

- 3. 2. 3.

  Estabelecimento de um fundo específico de manutenção, que assegure os recursos financeiros necessários para a conservação e atualização dos bens adquiridos, bem como para a continuidade dos serviços implementados.

3. 2. 4.

***Contratos de Manutenção e Serviços:***

- 3. 2. 5.

  Celebrar contratos de manutenção preventiva e corretiva para as infraestruturas físicas e os equipamentos tecnológicos, garantindo que as unidades de saúde se mantenham operacionais e em conformidade com os padrões de qualidade.

- 3. 2. 6.

  Assegurar que os contratos incluam cláusulas de desempenho, com prazos definidos para reparos e atualizações, a fim de minimizar interrupções nos serviços.

3. 2. 7.

***Desenvolvimento de Sistemas de Monitoramento:***

- 3. 2. 8.

  Implantar sistemas integrados de monitoramento e avaliação dos serviços e infraestruturas, permitindo a detecção precoce de falhas e a implementação de ações corretivas.

- 3. 2. 9.

  Utilização de indicadores previamente definidos (seguindo metodologia SMART) para acompanhamento contínuo do desempenho dos produtos implementados, possibilitando ajustes e aprimoramentos regulares.

3. 2. 10.

***Capacitação e Transferência de Conhecimento:***

- 3. 2. 11.

  Realizar capacitações periódicas para os servidores públicos e gestores das unidades de saúde, com o objetivo de transferir conhecimentos e boas práticas adquiridas durante o projeto.

- 3. 2. 12.

  Estabelecer parcerias com instituições de ensino e consultorias especializadas para a formação contínua, garantindo que a equipe mantenha-se atualizada em relação às novas tecnologias e métodos de gestão.

3. 2. 13.

***Instrumentos de Prestação de Contas e Transparência:***

- 3. 2. 14.

  Implementar mecanismos de prestação de contas, com a divulgação regular de relatórios de manutenção, utilização de equipamentos e desempenho dos serviços, para assegurar a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos.

- 3. 2. 15.

  A criação de um sistema de auditoria interna e externa para monitorar a sustentabilidade operacional e financeira do projeto, proporcionando segurança quanto ao uso dos recursos e à continuidade dos investimentos.

**Previsão dos Custos de Manutenção:**
Os custos de manutenção dos produtos e serviços decorrentes do projeto serão estimados com base na experiência de projetos anteriores e nas necessidades específicas de cada unidade. Esses custos englobarão:

- 3. 2. 16.

  Manutenção preventiva e corretiva das obras e equipamentos, incluindo atualizações tecnológicas e reparos estruturais.

- 3. 2. 17.

  Despesas operacionais relativas à atualização dos sistemas de informação e manutenção das soluções digitais (telemedicina, prontuários eletrônicos).

- 3. 2. 18.

  Custos de capacitação contínua e de suporte técnico para as equipes envolvidas.

Esses custos serão projetados para serem cobertos por repasses regulares orçados no PPA e na Lei Orçamentária Anual, garantindo a sustentabilidade financeira do programa mesmo após a fase de implementação. A SES/SP assumirá a responsabilidade pela continuidade dos investimentos, contando com o comprometimento dos órgãos de planejamento e da Secretaria de Fazenda para assegurar a alocação dos recursos necessários.

Portanto, a operacionalização e a manutenção das ações implementadas são garantidas por uma estrutura integrada que combina planejamento orçamentário, contratos de manutenção, sistemas de monitoramento, capacitação contínua e mecanismos de prestação de contas. Essas medidas asseguram que as melhorias introduzidas pelo projeto se mantenham e evoluam ao longo do tempo, promovendo um SUS mais eficiente, resiliente e sustentável, em alinhamento com os padrões e diretrizes estabelecidos pelo BID, pelo PPA e pelas políticas públicas do Governo Federal.

## 3. 3. **Planejamento Estratégico**

O presente projeto está estrategicamente enquadrado no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado de São Paulo, especialmente no âmbito do Programa 930 – Atendimento Integrado e Regionalizado no SUS no Estado de São Paulo. Este programa tem como finalidade promover a ampliação e o aperfeiçoamento dos serviços de saúde, garantindo o acesso universal e a integralidade do atendimento, em consonância com as diretrizes constitucionais e com as demandas da população.

**Enquadramento no PPA 2024-2027:**

3. 3. 1.

***Programa 930 – Atendimento Integrado e Regionalizado no SUS/SP:***
O projeto contribui diretamente para as metas estabelecidas neste programa, que visa fortalecer a rede de serviços públicos de saúde, ampliar o acesso, modernizar as infraestruturas e aprimorar os mecanismos de gestão e integração dos serviços. As ações propostas – que abrangem a modernização da infraestrutura, a implantação de soluções digitais, a construção de novos hospitais e o fortalecimento da governança – estão alinhadas com o escopo do Programa 930, buscando proporcionar um atendimento mais rápido, integrado e de qualidade aos usuários do SUS.

3. 3. 2.

***Objetivos Específicos e Entregas:***

- 3. 3. 3.

  *Objetivo Estratégico 102* – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade: O projeto promove a expansão da oferta assistencial por meio de intervenções que modernizam unidades de saúde, constroem novos hospitais em áreas prioritárias e implementam tecnologias que facilitam a comunicação e o atendimento remoto.

- 3. 3. 4.

  *Objetivo Estratégico 214* – Reduzir as desigualdades regionais: As ações de descentralização e modernização das unidades assistenciais visam reduzir a concentração de serviços em grandes centros urbanos, garantindo que regiões vulneráveis e historicamente desassistidas tenham acesso a cuidados especializados.

- 3. 3. 5.

  *Objetivo Estratégico 302* – Promover o aperfeiçoamento das capacidades estatais: A criação de estruturas de governança, oficinas regionais e a implantação de uma Unidade de Coordenação do Projeto fortalecem a capacidade de gestão dos órgãos de saúde, promovendo uma administração mais eficiente e integrada.

- 3. 3. 6.

  *Objetivo Estratégico 303* – Intensificar a transformação digital: A adoção de tecnologias como prontuários eletrônicos, telemedicina e sistemas integrados contribui para a modernização dos processos assistenciais, agilizando a comunicação e a regulação dos serviços.

3. 3. 7.

***Medidas Institucionais e Normativas:***

- 3. 3. 8.

  O projeto está em conformidade com as normas estabelecidas pelo PPA 2024-2027 do Estado de São Paulo, que priorizam o atendimento integrado e regionalizado no SUS.

- 3. 3. 9.

  As ações também se fundamentam nas diretrizes do Plano Estadual de Saúde (PES) e no Plano Regional Integrado (PRI), garantindo que as intervenções estejam alinhadas com as políticas públicas federais e estaduais.

- 3. 3. 10.

  A certificação LEED para sustentabilidade ambiental dos equipamentos e construções reforça a adesão a medidas normativas e internacionais de qualidade e sustentabilidade.

3. 3. 11.

***Integração com Documentos de Planejamento Setorial:***

- 3. 3. 12.

  Além do PPA, o projeto se alinha aos instrumentos de planejamento estratégico da SES/SP e aos documentos de diretrizes do Governo Federal, que enfatizam a importância da regionalização, da descentralização dos serviços de saúde e da transformação digital no setor.

- 3. 3. 13.

  A coordenação centralizada, por meio da UCP, e a participação de órgãos como COSEMS e DRS garantem que as ações estejam integradas e ajustadas às necessidades locais, promovendo um sistema de saúde mais coeso e responsivo.

Além disso, é importante mencionar que ao longo das últimas décadas, o estado de São Paulo vem atuando fortemente no aperfeiçoamento do SUS/SP, ampliando e modernizando sua rede de serviços próprios e transferindo recursos para os Municípios investirem em seus equipamentos de saúde. Além de investimentos na infraestrutura, vem aprimorando os mecanismos de gestão, articuladamente com os gestores municipais.

**Plano Plurianual 2024-2027 do Estado de São Paulo:** https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/planejamento/Documents/PPA2024-2027/Anexo%20-%20PPA%202024-2027%20final.pdf.

https://1drv.ms/i/s!AjukZReTJZ9Qit99hw1S934zleZKdQ?e=TPDH4v

**Plano Estadual de Saúde 2024-2027**: https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/documentos-de-planejamento-em-saude/instrumentos-de-planejamento-do-sus-quadrienio-2024-a-2027/parte_2_pes_2024-2027_-matriz_do_pes-_domi.pdf.?

3. 4. **Anexos**

OORGANOGRAMA DO ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ARAS

Plurianual – PPA 2024-2027

Organograma SES/SP

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
**Nome:** Contratações
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Este risco diz respeito à possibilidade de atrasos e ineficiências no processo de contratações, especialmente na elaboração de documentos para licitações e na seleção de fornecedores qualificados. Entre as possíveis causas para esse evento, destacam-se:

- 4. 2.

  **Complexidade e Inadequação dos Documentos:**
  A elaboração de editais, termos de referência e demais documentos contratuais pode ser complexa e sujeita a erros. A falta de clareza ou de especificações técnicas precisas pode levar à necessidade de revisões e reprocessamentos, atrasando o cronograma do projeto.

- 4. 3.

  **Dificuldades na Seleção de Fornecedores:**
  A identificação e a contratação de fornecedores que atendam aos critérios de qualidade, prazos e conformidade podem ser desafiadoras, principalmente se houver um número limitado de fornecedores qualificados no mercado. Essa dificuldade pode resultar em processos licitatórios prolongados ou na contratação de fornecedores que não consigam cumprir os compromissos, afetando a execução das atividades.

- 4. 4.

  B**urocracia e Processos Administrativos:**
  Procedimentos internos complexos e exigências burocráticas podem atrasar a finalização dos processos de contratação, comprometendo a agilidade necessária para o início das atividades e a execução do projeto dentro dos prazos estabelecidos.

Os efeitos negativos potenciais desse risco sobre o projeto incluem:

- 4. 5.

  **Atrasos na Execução:**
  Atrasos nas contratações podem causar o adiamento do início das atividades, impactando o cronograma global do projeto e comprometendo a entrega dos resultados dentro dos prazos previstos.

- 4. 6.

  **Aumento dos Custos:**
  A necessidade de refazer ou revisar documentos, bem como a contratação de fornecedores inadequados que possam exigir ajustes posteriores, pode levar a custos adicionais e ao desperdício de recursos.

- 4. 7.

  **Redução da Qualidade dos Serviços:**
  Se fornecedores não qualificados forem contratados devido a processos inadequados, a qualidade dos bens ou serviços fornecidos poderá ser comprometida, afetando diretamente a eficiência e a eficácia das intervenções planejadas.

- 4. 8. **Impacto na Credibilidade do Projeto:**

  Atrasos e falhas nas contratações podem reduzir a confiança dos financiadores, da população e dos demais parceiros institucionais, prejudicando a imagem e a reputação do projeto.

**Prevenção e Mitigação:**

- 4. 9.

  Padronização e Qualificação dos Documentos:

  - 4. 10.

    Ação: Desenvolver modelos padronizados de editais, termos de referência e demais documentos contratuais, com especificações técnicas detalhadas e critérios de seleção claros.

  - 4. 11.

    Responsáveis: Equipe da UCP, com apoio do setor jurídico e consultorias especializadas.

- 4. 12.

  Capacitação da Equipe de Licitações:

  - 4. 13.

    Ação: Realizar treinamentos periódicos para a equipe responsável pelos processos licitatórios e contratações, visando aprimorar a elaboração dos documentos e a avaliação das propostas, de modo a garantir a seleção de fornecedores qualificados e com histórico comprovado.

  - 4. 14.

    Responsáveis: UCP e setor de Recursos Humanos da SES/SP, em parceria com consultorias especializadas.

- 4. 15.

  Estabelecimento de Cronogramas e Ferramentas de Gestão:

  - 4. 16.

    Ação: Definir cronogramas detalhados para cada etapa dos processos licitatórios e contratações, utilizando ferramentas de gestão de projetos para monitorar prazos e identificar possíveis atrasos, possibilitando intervenções imediatas.

  - 4. 17.

    Responsáveis: UCP, com suporte do departamento de Planejamento.

- 4. 18.

  Implementação de Mecanismos de Avaliação de Desempenho dos Fornecedores:

  - 4. 19.

    Ação: Criar um sistema de avaliação contínua dos fornecedores contratados, com indicadores de desempenho e satisfação, que permita a identificação de problemas e a adoção de medidas corretivas de forma proativa.

  - 4. 20.

    Responsáveis: UCP, em conjunto com o setor de Compras e Contratos da SES/SP.

Essas ações visam garantir a eficiência e a eficácia dos processos de contratação, reduzindo atrasos, evitando revisões e garantindo a seleção de fornecedores capazes de atender aos requisitos técnicos e de qualidade exigidos pelo projeto.

4. 21. **Informações do 2° risco:**
**Nome:** Legais
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Este risco refere-se à possibilidade de impedimentos legais que possam atrasar ou dificultar a execução do projeto, afetando a obtenção de licenças, autorizações e demais documentos regulamentares necessários. As possíveis causas para esse evento incluem:

- 4. 22.

  **Complexidade Regulatória:** A existência de múltiplas normas e exigências legais em diferentes esferas governamentais (federal, estadual e municipal) pode gerar burocracia excessiva e atrasos na liberação de licenças e autorizações.

- 4. 23.

  **Mudanças na Legislação:** Alterações ou interpretações divergentes das leis e regulamentos podem impactar negativamente o andamento do projeto, exigindo adequações não previstas inicialmente.

- 4. 24.

  **Inconsistências nos Processos de Aprovação:** Falhas na coordenação entre os órgãos responsáveis pela análise e aprovação dos processos podem resultar em atrasos e na necessidade de reprocessamento dos documentos.

- 4. 25.

  **Conflitos de Interesses e Demandas Jurídicas:** Litígios ou contestações judiciais relacionados a questões ambientais, de desapropriação, de indenizações ou outros aspectos legais podem impedir ou retardar a execução das atividades planejadas.

Os efeitos negativos potenciais deste risco sobre o projeto incluem:

- 4. 26.

  **Atrasos na Execução:** A demora na obtenção de licenças e autorizações pode comprometer o cronograma do projeto, atrasando a implementação das obras e intervenções.

- 4. 27.

  **Aumento dos Custos:** A readequação de processos e a necessidade de reavaliação dos procedimentos legais podem gerar custos adicionais, impactando a eficiência orçamentária do projeto.

- 4. 28.

  **Comprometimento da Credibilidade:** Impedimentos legais e atrasos podem afetar a imagem do projeto perante a população, financiadores e parceiros institucionais, comprometendo a confiança no programa.

- 4. 29.

  **Redução da Escalabilidade:** Se as barreiras legais persistirem, o projeto poderá ter dificuldade em replicar suas soluções em outras regiões, limitando seu impacto e potencial de transformação.

**Prevenção e Mitigação:**

- 4. 30. **Assessoria Jurídica Especializada:**

- 4. 31.

  Ação: Contratar e manter uma equipe jurídica especializada para acompanhar continuamente as mudanças na legislação e garantir a conformidade dos processos licitatórios e operacionais do projeto.

- 4. 32.

  Responsáveis: Setor Jurídico da SES/SP e Unidade de Coordenação do Projeto (UCP).

- 4. 33.

  **Mapeamento e Análise Regulatória:**

  - 4. 34.

    Ação: Realizar um estudo aprofundado das normativas e exigências legais (ambientais, sanitárias e urbanísticas) aplicáveis ao projeto, identificando possíveis entraves e definindo estratégias para sua mitigação.

  - 4. 35.

    Responsáveis: UCP, com apoio de consultorias jurídicas e especialistas em regulação.

- 4. 36.

  **Planejamento Antecipado para Licenças e Autorizações:**

  - 4. 37.

    Ação: Estabelecer um cronograma específico para a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias, submetendo os documentos com antecedência e monitorando o progresso junto aos órgãos licenciadores.

  - 4. 38.

    Responsáveis: UCP e Departamento de Licenciamento da SES/SP.

- 4. 39.

  **Implementação de Mecanismos de Resolução de Conflitos:**

  - 4. 40.

    Ação: Desenvolver e formalizar procedimentos internos para resolução de eventuais litígios ou contestações que possam surgir durante a execução do projeto, com mediação de instâncias especializadas.

  - 4. 41.

    Responsáveis: UCP, com suporte do setor jurídico e de órgãos de governança do projeto.

- 4. 42.

  **Monitoramento e Revisão Periódica:**

  - 4. 43.

    Ação: Estabelecer revisões regulares dos processos legais e regulatórios para identificar e corrigir possíveis falhas, assegurando que o projeto se mantenha em conformidade com as exigências legais.

  - 4. 44.

Responsáveis: UCP e equipe de monitoramento jurídico.

Essas ações, implementadas de forma integrada, visam minimizar os riscos legais, assegurando que o projeto opere de acordo com as normas e regulamentos vigentes, evitando atrasos e custos adicionais decorrentes de impedimentos legais.

4. 45. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Arranjos regionais e de governança
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Esse risco diz respeito à dificuldade de coordenação e integração entre os diversos atores envolvidos na implementação do projeto, incluindo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), as Secretarias Municipais de Saúde e o COSEMS. Entre os principais desafios, destacam-se:

- 4. 46.

  **Conflitos de interesse:** Divergências entre as prioridades dos municípios e dos órgãos estaduais podem levar à desarticulação das ações.

- 4. 47.

  **Falta de engajamento:** A ausência de comprometimento ou participação ativa dos gestores municipais pode dificultar a execução conjunta das ações planejadas.

- 4. 48.

  **Dificuldade na comunicação:** Barreiras na comunicação entre os diferentes níveis de gestão podem resultar em atrasos, redundâncias ou mesmo na perda de informações críticas para a coordenação regional.

Esses fatores podem acarretar atrasos na implementação das medidas, comprometer a efetividade do processo de regionalização e reduzir o impacto esperado do projeto na melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de saúde.

**Prevenção e Mitigação:**
Para prevenir ou mitigar o risco, as seguintes ações serão adotadas, com a respectiva definição dos responsáveis pela execução:

- 4. 49.

  **Criação de Comitês Executivos de Governança Regional:**

  - 4. 50.

    ***Descrição:*** Estabelecer comitês integrados com representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES), dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), das Secretarias Municipais de Saúde e do COSEMS, para alinhar as ações, definir prioridades e resolver conflitos de interesse.

  - 4. 51.

    ***Responsáveis:*** A Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), em conjunto com os DRS e o COSEMS.

- 4. 52.

  **Realização de Oficinas e Treinamentos:**

  - 4. 53.

    ***Descrição:*** Organizar oficinas regionais e treinamentos específicos para capacitar os gestores e as equipes envolvidas, fortalecendo a cultura de cooperação e o engajamento dos municípios no processo de regionalização.

  - 4. 54.

    ***Responsáveis:*** A UCP, com apoio das consultorias especializadas contratadas e dos Departamentos Regionais de Saúde.

- 4. 55.

  **Estabelecimento de Protocolos de Comunicação Integrada:**

  - 4. 56.

    ***Descrição:*** Implantar ferramentas digitais e definir protocolos para a comunicação e a troca de informações entre os diversos atores do projeto, garantindo atualizações em tempo real e transparência nas decisões.

  - 4. 57.

    R***esponsáveis:*** A UCP, em coordenação com o setor de TI da SES e os DRS.

- 4. 58.

  **Monitoramento Contínuo e Sistema de Feedback:**

  - 4. 59.

    ***Descrição:*** Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho relacionados à governança (por exemplo, frequência de reuniões dos comitês e participação efetiva dos atores) e realizar avaliações periódicas para identificar eventuais falhas no engajamento.

  - 4. 60.

    ***Responsáveis:*** A UCP, com apoio da área de avaliação e monitoramento da SES.

Essas ações, implementadas de forma integrada e contínua, visam garantir a coordenação efetiva dos atores envolvidos, minimizar conflitos e promover um engajamento sustentável dos municípios, assegurando que o processo de regionalização e a gestão do projeto avancem de forma harmoniosa e eficaz.

4. 61. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Custeio dos Novos Hospitais
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Este risco diz respeito à possibilidade de o projeto enfrentar insuficiência de recursos financeiros para a manutenção e operação dos novos hospitais construídos ou modernizados, o que pode comprometer a sustentabilidade das unidades

assistenciais. As possíveis causas para esse evento incluem:

- 4. 62.

  **Subestimação dos Custos Operacionais:**
  Falhas na projeção dos custos de manutenção e operação, como despesas com energia, insumos, salários e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, podem levar a um déficit orçamentário que comprometa a continuidade dos serviços.

- 4. 63.

  **Incertezas no Repasse de Recursos:**
  A dependência de repasses orçamentários contínuos do PPA e da Lei Orçamentária Anual, além da coordenação entre os órgãos de planejamento e a Secretaria de Fazenda, pode gerar incertezas quanto à disponibilidade de recursos suficientes ao longo do tempo.

- 4. 64.

  **Variações Econômicas e Pressões Fiscais:**
  Situações de instabilidade econômica, com variações nos gastos públicos e pressões fiscais, podem reduzir a capacidade do governo de manter os investimentos correntes necessários para a operação adequada dos novos hospitais.

- 4. 65.

  **Mudanças nas Políticas Públicas:**
  Alterações nas prioridades políticas ou na administração pública, especialmente em períodos de transição governamental, podem afetar a continuidade do financiamento e do suporte institucional destinado à manutenção das unidades.

**Os efeitos negativos potenciais desse risco sobre o programa incluem:**

- 4. 66.

  **Sobrecarga do Sistema de Saúde:**
  Se os novos hospitais não tiverem os recursos necessários para sua manutenção, o atendimento pode ser comprometido, aumentando a pressão sobre outros centros de saúde e prejudicando a oferta de serviços especializados.

- 4. 67.

  **Redução da Qualidade do Atendimento:**
  A falta de recursos pode impactar a disponibilidade de equipamentos, insumos e profissionais qualificados, resultando em serviços de menor qualidade e em atrasos nos diagnósticos e tratamentos.

- 4. 68.

  **Impacto na Sustentabilidade do Projeto:**
  A insuficiência de custeio pode levar ao fechamento ou à desativação das unidades, revertendo os avanços alcançados e comprometendo os benefícios esperados, especialmente no que tange à descentralização e à redução das desigualdades regionais.

Essa descrição detalhada do risco evidencia a importância de um planejamento orçamentário robusto e de mecanismos de acompanhamento contínuo, de modo a mitigar os efeitos adversos e assegurar a sustentabilidade financeira dos novos hospitais ao longo do tempo.

**Prevenção e Mitigação:**
Para mitigar o risco relacionado à insuficiência de recursos para a manutenção e operação dos novos hospitais, serão adotadas as seguintes ações, com definição clara dos responsáveis por cada iniciativa:

4. 68. 1.

**Elaboração de Projeções Orçamentárias Detalhadas:**

- 4. 68. 2.

  ***Ação:*** Realizar um estudo detalhado dos custos operacionais, incluindo despesas com manutenção, energia, insumos, salários e serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

- 4. 68. 3.

  ***Responsáveis:*** Equipe de planejamento financeiro da SES, com apoio de consultorias especializadas e setor de controle orçamentário.

4. 68. 4.

**Inclusão de Custos Correntes no Planejamento Orçamentário:**

- 4. 68. 5.

  ***Ação:*** Integrar os custos de manutenção e operação dos novos hospitais na programação do PPA e na Lei Orçamentária Anual, garantindo repasses contínuos para a sustentabilidade das unidades.

- 4. 68. 6.

  ***Responsáveis:*** Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

4. 68. 7.

**Criação de um Fundo de Manutenção Específico:**

- 4. 68. 8.

  ***Ação:*** Estabelecer um fundo destinado exclusivamente à manutenção e operação dos novos hospitais, a ser alimentado com parte dos recursos destinados ao projeto e por repasses orçamentários regulares, assegurando a disponibilidade de recursos para custeio contínuo.

- 4. 68. 9.

  ***Responsáveis:*** Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e setor de planejamento financeiro da SES/SP.

4. 68. 10.

**Acompanhamento Contínuo e Revisão Periódica dos Custos:**

- 4. 68. 11.

  ***Ação:*** Implantar um sistema de monitoramento financeiro que permita a avaliação contínua dos custos operacionais dos novos hospitais e a identificação precoce de desvios orçamentários, possibilitando a implementação de medidas corretivas imediatas.

- 4. 68. 12.

  ***Responsáveis:*** UCP, com suporte da equipe de monitoramento e avaliação da SES/SP e do Departamento de Planejamento.

4. 68. 13.

**Estabelecimento de Parcerias para Otimização de Custos:**

- 4. 68. 14.

  ***Ação:*** Buscar parcerias com instituições e fornecedores que possam oferecer condições vantajosas para a manutenção dos equipamentos e serviços, como contratos de manutenção em regime de parceria público-privada (PPP) ou licitações com critérios de custo-benefício que garantam preços competitivos e qualidade nos serviços.

- 4. 68. 15.

  ***Responsáveis:*** Comissão de Licitações da SES/SP, com apoio da UCP e do setor jurídico.

4. 68. 16.

**Revisão e Ajuste das Políticas de Financiamento:**

- 4. 68. 17.

  ***Ação:*** Manter diálogo permanente com os órgãos de planejamento e com a Secretaria de Fazenda para ajustar as políticas de financiamento, de forma a responder rapidamente a eventuais mudanças econômicas e garantir a continuidade do suporte financeiro ao projeto, mesmo em períodos de transição de governo.

- 4. 68. 18.

  ***Responsáveis:*** Gabinete do Secretário e UCP, em articulação com a Secretaria de Fazenda.

Essas ações, implementadas de forma coordenada, visam minimizar o risco de insuficiência de custeio, garantindo que os novos hospitais operem de maneira sustentável, com recursos financeiros adequados para manter a qualidade dos serviços e assegurar o alcance dos resultados esperados pelo projeto.

4. 69. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Atraso nas Entregas de Licitações e Obras
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Este risco refere-se à possibilidade de atrasos nos processos licitatórios e na execução das obras e intervenções previstas no projeto. As possíveis causas para esse evento incluem:

- 4. 70.

  **Falhas na Elaboração dos Documentos:**
  Dificuldades na elaboração de editais e termos de referência claros e completos podem levar à seleção inadequada de fornecedores e à necessidade de reprocessamento dos procedimentos licitatórios.

- 4. 71.

  **Burocracia e Processos Administrativos:**
  A complexidade dos trâmites legais e administrativos, bem como a falta de integração entre os órgãos responsáveis, pode gerar atrasos significativos na aprovação e na execução das obras.

- 4. 72.

  **Problemas Logísticos e Técnicos:**
  Questões relativas à logística de transporte de materiais, disponibilidade de mão de obra qualificada e desafios técnicos na execução das obras podem contribuir para a postergação das entregas.

- 4. 73.

  **Dificuldades na Seleção de Fornecedores:**
  A dificuldade em identificar e contratar fornecedores que atendam aos critérios de qualidade e prazos pode atrasar o início das obras e comprometer o cronograma do projeto.

Os efeitos negativos potenciais deste risco sobre o projeto incluem:

- 4. 74.

  **Aumento dos Custos:**
  Atrasos podem resultar em custos adicionais, seja por reajustes contratuais ou pela necessidade de medidas emergenciais para compensar os atrasos.

- 4. 75.

  **Interrupção do Cronograma:**
  O não cumprimento dos prazos estabelecidos impacta diretamente a conclusão das fases do projeto, prejudicando a entrega dos resultados esperados e a satisfação dos usuários.

- 4. 76.

  **Perda de Credibilidade:**
  A postergação das entregas e a má gestão dos prazos podem afetar a confiança da população e dos financiadores, comprometendo a imagem do projeto e de seus parceiros institucionais.

- 4. 77. **Impacto na Qualidade dos Serviços:**
  O atraso na execução das obras pode resultar em uma infraestrutura defasada, afetando a capacidade do sistema de saúde de oferecer um atendimento ágil e de qualidade.

**Prevenção e Mitigação:**
Para mitigar o risco de atrasos nos processos licitatórios e na execução das obras, serão adotadas as seguintes ações, com a designação clara dos responsáveis:

4. 77. 1.

**Elaboração de Documentos Técnicos com Alto Nível de Precisão:**

- 4. 77. 2.

  Ação: Desenvolver editais, termos de referência e contratos de forma detalhada e padronizada, garantindo que todos os critérios de qualidade, prazos e requisitos técnicos estejam explicitados.

- 4. 77. 3.

  Responsáveis: Equipe técnica da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), com suporte do setor jurídico e consultorias especializadas.

4. 77. 4.

**Simplificação e Integração dos Processos Administrativos:**

- 4. 77. 5.

  Ação: Revisar e otimizar os trâmites burocráticos internos para acelerar a aprovação de licitações e a liberação de recursos. Implantar sistemas digitais de gerenciamento de processos que facilitem a comunicação e a integração entre os órgãos envolvidos.

- 4. 77. 6.

  Responsáveis: UCP, em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde e os Departamentos Regionais de Saúde (DRS).

4. 77. 7.

**Capacitação e Treinamento da Equipe de Licitações e Contratos:**

- 4. 77. 8.

  Ação: Realizar treinamentos específicos para as equipes responsáveis pela elaboração de editais e pela condução dos processos licitatórios, visando aumentar a eficiência e reduzir erros que possam ocasionar retrabalho ou atrasos.

- 4. 77. 9.

  Responsáveis: UCP e setor de Recursos Humanos da SES, em parceria com consultorias especializadas.

4. 77. 10.

**Estabelecimento de Cronogramas Detalhados e Ferramentas de Monitoramento:**

- 4. 77. 11.

  Ação: Definir cronogramas robustos para cada fase dos processos licitatórios e obras, utilizando ferramentas de gestão de projetos (como gráficos de Gantt e sistemas de monitoramento digital) para acompanhar prazos e identificar antecipadamente possíveis desvios.

- 4. 77. 12.

  Responsáveis: UCP, com apoio do departamento de Planejamento e dos DRS.

4. 77. 13.

**Seleção de Fornecedores e Parceiros com Histórico Comprovado:**

- 4. 77. 14.

  Ação: Realizar uma pré-qualificação rigorosa de fornecedores e prestadores de serviços, com base em seu histórico de desempenho e capacidade técnica, para minimizar riscos de atrasos decorrentes de ineficiências na execução.

- 4. 77. 15.

  Responsáveis: Comissão de Licitações da SES, sob coordenação da UCP e apoio do setor jurídico.

4. 77. 16.

**Sistema de Feedback e Acompanhamento Contínuo:**

- 4. 77. 17.

  Ação: Implantar um sistema de feedback contínuo que permita a coleta e análise de dados referentes aos prazos de execução, possibilitando ajustes imediatos e a correção de eventuais falhas no processo.

- 4. 77. 18. Responsáveis: UCP, em conjunto com a área de Monitoramento e Avaliação da SES.

4. 78. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Transição de Governo Estadual
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Este risco refere-se à possibilidade de ocorrência de uma mudança de governo estadual que possa alterar as prioridades políticas, interromper financiamentos e reduzir o apoio institucional ao projeto. As possíveis causas para esse evento incluem a troca de administração durante períodos eleitorais ou em decorrência de crises políticas, que podem resultar em novas orientações estratégicas ou na realocação de recursos a outras áreas. Tais mudanças podem gerar incertezas e descontinuidades no fluxo de financiamento e no suporte institucional, afetando diretamente a execução e a continuidade das ações propostas.

Os efeitos negativos potenciais deste risco sobre o projeto incluem:

- 4. 79.

  **Interrupção do Financiamento:** Uma transição de governo pode levar à reavaliação ou à redução dos recursos destinados ao projeto, comprometendo a manutenção e a operação das ações já iniciadas.

- 4. 80.

  **Desalinhamento das Prioridades:** Novas diretrizes políticas podem desviar o foco do projeto, alterando as metas e objetivos originalmente estabelecidos e dificultando a integração das ações com o planejamento estratégico do SUS.

- 4. 81.

  **Perda de Apoio Institucional:** A mudança de governo pode resultar na diminuição do engajamento dos órgãos e parceiros envolvidos, enfraquecendo os mecanismos de coordenação e a execução das atividades, além de afetar a confiança dos financiadores e da população.

- 4. 82.

  **Atrasos e Interrupções na Execução:** A incerteza gerada pela transição pode atrasar processos decisórios, reconfigurar contratos e modificar cronogramas, impactando diretamente a conclusão das obras e a implementação das soluções tecnológicas e assistenciais previstas.

Essa descrição evidencia que a transição de governo estadual é um evento adverso com impacto potencialmente alto, devido à sua capacidade de interromper o financiamento e alterar a dinâmica de governança, prejudicando a execução do projeto e comprometendo os resultados esperados.

**Prevenção e Mitigação:**
Para mitigar os riscos decorrentes de uma eventual transição de governo estadual, as seguintes ações serão implementadas:

- 4. 83.

  **Formalização de Compromissos e Acordos Institucionais:**

  - 4. 84.

    Estabelecer contratos, portarias e instrumentos legais que assegurem a continuidade do financiamento e o suporte institucional ao projeto, independentemente de mudanças na administração pública.

- 4. 85.

  Responsáveis: Gabinete do Secretário e UCP, com apoio do setor jurídico.

- 4. 86.

  **Inclusão de Metas no PPA e na Lei Orçamentária Anual:**

  - 4. 87.

    Incorporar as ações e metas do projeto ao PPA e à Lei Orçamentária Anual, garantindo que o repasse de recursos e o comprometimento financeiro sejam mantidos durante e após a transição.

  - 4. 88.

    Responsáveis: SES/SP, em articulação com a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

- 4. 89.

  **Estabelecimento de Mecanismos de Monitoramento e Comunicação Contínua:**

  - 4. 90.

    Implantar sistemas de monitoramento e relatórios periódicos para acompanhar a execução do projeto, com divulgação transparente dos resultados para todos os atores envolvidos, fortalecendo a confiança e a continuidade dos investimentos.

  - 4. 91.

    Responsáveis: UCP, com suporte da área de Monitoramento e Avaliação.

- 4. 92.

  **Engajamento e Capacitação dos Gestores:**

  - 4. 93.

    Realizar treinamentos e workshops para assegurar que os gestores estejam alinhados com as diretrizes do projeto, independentemente das mudanças administrativas, garantindo a continuidade das práticas e políticas adotadas.

  - 4. 94.

    Responsáveis: UCP e Departamentos Regionais de Saúde.

- 4. 95.

  **Diálogo Institucional e Articulação com Órgãos de Controle:**

  - 4. 96.

    Manter um canal de comunicação contínuo com os órgãos de controle e com a sociedade para demonstrar os benefícios e a relevância do projeto, incentivando o apoio mesmo diante de mudanças políticas.

- 4. 97.

  Responsáveis: Gabinete do Secretário e UCP.

Essas ações visam assegurar que, mesmo em um cenário de transição de governo, o projeto mantenha seu fluxo de financiamento, o engajamento institucional e a continuidade das

atividades, minimizando os efeitos negativos associados à mudança de prioridades e garantindo a execução das metas propostas.

4. 98. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD |
|---|---|---|---|---|
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | Real | 0.1747 | 1.076.250.000,00 | 188.020.875,00 |

#### 5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 60 | 228 | 288 |

**Juros aplicáveis:**
CDI - Vida Média Ponderada (VMP) no momento de cada desembolso + Margem de Capital Ordinário (margem definida anualmente pelo Diretório do BID, fixada em 0,8% ao ano para 2025). Tabela VPM em anexo.
**Periodicidade dos Pagamentos:**
Semestral, tanto dos juros quanto das amortizações
**Comissão de Compromisso:**
até 0,75% ao ano, hoje é de 0,5%
**Comissão de Avaliação:**
0,00
**Taxa de Abertura:**
0,00
**Outros encargos:**

n/a

**Outras Informações:**

n/a

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOIO À GESTÃO DO SUS EM SÃO PAULO COM ÊNFASE NOS PROCESSOS DE REGIONALIZAÇÃO | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F1 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 9.184.000,00 | 0,00 | 11.480.000,00 | 0,00 | 13.776.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 6.888.000,00 | 0,00 | 4.592.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F1 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 123.984.000,00 | 0,00 | 154.980.000,00 | 0,00 | 185.976.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 92.988.000,00 | 0,00 | 61.992.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE DIGITAL | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F1 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 34.440.000,00 | 0,00 | 43.050.000,00 | 0,00 | 51.660.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 25.830.000,00 | 0,00 | 17.220.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL (Contrapartida) | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F1 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 43.050.000,00 | 0,00 | 53.812.500,00 | 0,00 | 64.575.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 32.287.500,00 | 0,00 | 21.525.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTÃO DO PROGRAMA | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F1 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 4.592.000,00 | 0,00 | 5.740.000,00 | 0,00 | 6.888.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 3.444.000,00 | 0,00 | 2.296.000,00 | 0,00 | | |

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantia à garantia da União, as receitas discriminadas no § 4° do artigo 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito.

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos. Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as receitas discriminadas no §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

O referido parágrafo, traz que é "permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia".

Cabe observar, com o intuito de ilustrar a autorização que consta da Lei, no que tange ao Estado, tem-se principalmente as receitas do:

- 5. 4. art. 155 (Inciso I - Imposto transmissão causa mortis e doação; Inciso II - ICMS; Inciso III - IPVA);
- 5. 5. art. 156-A (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS);
- 5. 6. art. 157 (Inciso I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; Inciso II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I); e
- 5. 7. art. 159 (Inciso I - vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; Inciso II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

5. 8. **Anexos**

TABELA DE VPM

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

Durante o período de preparação e implantação das ações que fundamentaram o projeto, foram realizadas diversas etapas estratégicas que serviram como alicerce para o desenvolvimento do Programa ARAS. Essas iniciativas, acumuladas ao longo do ciclo anterior do Programa Saúde em Ação (2014-2021), contribuíram significativamente para a compreensão das necessidades regionais e o aprimoramento das práticas de gestão e assistência no SUS. A seguir, detalham-se as principais etapas realizadas:

6. 1. 1.

**Execução do Programa Saúde em Ação (2014-2021):**

- 6. 1. 2.

  ***Implementação Assistencial:*** Foram executadas intervenções, na lógica das Redes de Atenção, em 71 municípios prioritários, identificados como os mais vulneráveis, atendendo aproximadamente 10% da população do Estado. Neste período, novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), Hospitais e Ambulatórios de Especialidades foram criados ou modernizados, ampliando a oferta de serviços e descentralizando o atendimento.

- 6. 1. 3.

  ***Informatização e Tecnologia:*** Todas as UBS dos municípios priorizados passaram por processos de informatização com a implantação do sistema e-SUS PEC, melhorando a coleta e o monitoramento dos dados clínicos e epidemiológicos.

- 6. 1. 4.

  ***Capacitação de Profissionais:*** Diversas ações de treinamento e qualificação foram realizadas, incluindo cursos de especialização em Gestão da Clínica e seminários de capacitação para gestores. Foram organizadas diversas sessões de capacitação para profissionais e gestores, abordando temas críticos como comunicação eficiente, financiamento, judicialização e liderança. Esses treinamentos não só melhoraram o desempenho operacional das equipes, como também promoveram a disseminação de boas práticas e a criação de uma cultura de regionalização e inovação.

- 6. 1. 5. ***LInhas de Cuidado:*** Foram desenvolvidas em parcerias com Grandes Universidades as LInhas de Cuidado da Gestante, Parturiente e Puérpera, da Criança e de Hipertensão e Diabetes.

6. 1. 6.

***Estruturação do Processo de Regionalização:***

- 6. 1. 7. ***Oficinas Regionais e Consultorias:*** Iniciou-se um processo para a reprogramação da regionalização da saúde no Estado, com a realização de oficinas regionais que envolveram gestores estaduais, municipais e representantes de COSEMS. Essas oficinas permitiram o alinhamento de políticas e a definição de prioridades, reforçando a integração e a coordenação dos serviços em cada região.
- 6. 1. 8.

  ***Estudos Epidemiológicos:*** Foram conduzidos estudos aprofundados para mapear o perfil epidemiológico das regiões, com destaque para as principais causas de mortalidade – doenças cardiovasculares, neoplasias e patologias do sistema respiratório – e o aumento de mortes prematuras por condições crônicas, como diabetes mellitus.

- 6. 1. 9. ***Análise da Infraestrutura:*** Avaliou-se a capacidade instalada das unidades assistenciais, identificando deficiências físicas e tecnológicas que impactavam a eficiência dos atendimentos. Esse diagnóstico permitiu a priorização das regiões e a definição de estratégias para a modernização e expansão da rede de serviços.
- 6. 1. 10.

***Constituição de Comitês de Governança:*** Foram formados Comitês Executivos de Governança Regional, que passaram a atuar como espaços de articulação e tomada de decisão conjunta, assegurando a coesão das ações e a continuidade dos processos de regionalização.

- 6. 1. 11.

***Incentivo Financeiro:*** Implantação do Incentivo para a Gestão Municipal – IGM, para a qualificação da Atenção Primária e qualificação e expansão da capacidade instalada nos Hospitais Filantrópicos e Autarquias, em diversos procedimentos com a criação da Tabela SUS Paulista.

6. 1. 12.

**Formalização de Parcerias e Instrumentos de Planejamento:**

- 6. 1. 13.

***Termos de Cooperação:*** Foram celebrados acordos de cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde e outras entidades, como a Secretaria de Gestão e Governo Digital, com o objetivo de articular esforços para a implementação do Componente de Saúde Digital, bem como outras ações estratégicas do projeto.

- 6. 1. 14.

***Integração com Documentos de Planejamento:*** As diretrizes e metas definidas durante o Programa Saúde em Ação foram incorporadas aos instrumentos de planejamento estratégico do SUS, como o Plano Estadual de Saúde (PES) e o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, proporcionando continuidade e estabilidade institucional.

As etapas realizadas até o momento formam a base sólida sobre a qual o Projeto ARAS será implementado. O legado do Programa Saúde em Ação, com suas inovações assistenciais, avanços tecnológicos e fortalecimento da governança, fornece os insumos essenciais para a continuidade e ampliação dos esforços. Essa experiência prévia demonstrou a viabilidade e o potencial de impacto das intervenções, permitindo que o projeto se consolide como uma estratégia eficaz para a regionalização e a modernização do SUS, visando melhorar o acesso, reduzir desigualdades e aprimorar a qualidade dos serviços de saúde no Estado de São Paulo.

## 6. 2. **Anexos**

Sem anexos.